

시민성 중심 교육과정 개발 및 적용

1차년도 성과 정리본 · 2025-2026

의학전문직업성을 민주사회의 시민적 차원으로 확장하고, 대학이 교육과정에 적용할 수 있는 성과체계와 공유 강의 설계를 마련했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

핵심 성과

6개 · 교육 영역·졸업성과

18개 · 세부성과

12회분 · 강의계획 확정

- 시민적 전문직업성을 개념적 기반으로 6개 영역·6개 졸업성과·18개 세부성과 체계를 확정했습니다.
- KGO 2판 18개 성과 중 10개와 대응시킨 매칭표와 교육과정 통합 구조표를 마련했습니다.
- 문화적 다양성과 공존 영역을 우선 개발하여 25분 기준 12회분 강의계획을 확정했습니다. 영상 촬영·탑재는 진행 중입니다.
- 산출물 9종 중 7종은 완료, 영상과 논문 2종은 진행 중으로 보고했습니다.
- 시민성 교육의 의미와 방향에 관한 논문은 수정 통보 후 리비전 준비 단계이며, 2025년 KAMC Annual Meeting에서 중간 성과를 발표했습니다.

주요 산출물

- 시민성 성과체계·KGO 매칭표
- 교육과정 통합 구조표
- 문화적 다양성과 공존 모듈계획
- 논문 원고·학술발표

세부 성과 목차

- 01 · 추진 배경 및 이론적 배경
- 02 · 과제 목표 및 성과지표
- 03 · 추진 체계 및 방법
- 04 · 추진 경과 및 실적
- 05 · 주요 결과 및 성과물
- 06 · 성과지표 달성도 및 자체평가
- 07 · 성과 확산 및 활용 방안
- 08 · 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

01 추진 배경 및 이론적 배경

1. 추진 배경 및 필요성

가. 정책·제도적 배경

한국 의학교육은 회원교가 공통으로 참조할 교육과정 체계를 재설계하고 있다. KAMC는 그 체계로 Core plus 교육과정을 도입하였다. 코어(core)는 전국 의과대학이 공통으로 갖추어야 할 필수 교육 내용이고, 플러스(plus)는 각 대학이 선택적으로 더하는 영역이다. 본 과제의 시민성 교육은 플러스 영역에 해당하며, 무엇을 가르칠 것인가라는 질문에 대한 응답의 하나로 사업 안에 배치되었다.

배경의 두 번째 축은 최근의 의정갈등이다. 의과대학 정원 정책을 둘러싼 갈등은 의료전문직이 사회와 맺는 관계를 어떻게 형성하고 교육할 것인가라는 과제를 의학교육에 남겼다. 의료인력과 의료자원의 배분처럼 사회 기본 구조에 관한 사안에서 전문직의 집단적 목소리가 공공선의 옹호와 직역 이익의 옹호 사이에서 사회적 신뢰의 시험대에 놓인다는 사실이 확인되었기 때문이다. 이 경험은 개별 진료의 윤리를 다루는 기존 전문직업성 교육의 범위만으로는 대응하기 어려운 교육 과제를 제기하였다.

시민성 교육의 제도적 근거는 이미 마련되어 있다. 「한국의 의사상 2022」와 이에 근거한 KAMC 기본의학교육 졸업성과는 전문직업성과 사회적 책무성을 한국 의사가 갖추어야 할 핵심 역량으로 명시하고 있으며, 기본의학교육 인증기준(ASK)의 상당수 항목도 사회적 책무성을 반영하고 있다. 즉 사회적 차원은 성과체계와 인증기준에 이미 존재한다. 남은 과제는 그것을 교육의 실제, 곧 교육과정과 교수학습, 평가로 옮기는 데 있다.

나. 의학교육 현장의 문제 인식

문제의 핵심은 확장된 전문직업성 개념과 현행 교육 사이의 간극이다. 2002년 「새천년의 의학전문직업성: 의사헌장」이 전문직업성을 의료전문직과 사회 사이의 계약으로 규정한 이래, 개념은 개인의 덕목을 넘어 전문직 집단, 의료시스템, 나아가 사회구조와 형평의 차원으로 확장되어 왔다. 그러나 전문직업성 교육과 평가는 여전히 개별 학습자의 인지와 행동, 그리고 개인의 정체성 형성에 초점을 두고 있다. 전문직 집단의 집합적 책무와 사회구조에 대한 개입, 공공선을 둘러싼 공적 참여는 교육과정에 충분히 공식화되지 않은 채 주변부에 머물러 있다.

이 간극은 교육적 노력의 부족에서 오는 것이 아니라 현행 교육이 담고 선 개인 차원의 프레임 자체에서 온다. 본 과제의 문헌 검토는 이 프레임의 구조적 한계를 네 가지로 정리하였다. 네 한계는 교육 내용의 기반이 무엇을 담고 있는가, 교육이 어떤 조건에서 작동하는가, 그 규범이 학습자에게 어떻게 작용하는가, 사회적 문제 앞에서 무엇을 할 수 있는가의 차원에 각각 대응한다.

〈표〉 현행 전문직업성 교육의 네 가지 한계

구분	한계	내용
①	현장 프레임의 개인 한정	의사현장이 전문직업성을 "오로지 개별 의사의 책임"으로 다루었다. 교육이 이 프레임 위에 설계되는 한 학습자가 배우는 전문직업성은 개인의 태도·행동 규범에 머문다.
②	잠재교육과정의 지배	전문직 정체성을 실질적으로 결정하는 것은 공식 교육과정이 아니라 조직·제도·구조 차원에서 작동하는 잠재교육과정이다. 개인 차원의 프레임은 조직 관행과 평가·보상 구조에 개입할 개념적 수단을 갖지 못한다.
③	표준화의 억압	전문직업성이 단일한 덕목·행동 목록으로 정의되면 그 목록이 모든 학습자의 표준이 되고, 학습자의 다양한 배경·가치·정체성 차이가 존중할 다양성이 아니라 교정할 결함으로 처리될 위험이 있다.
④	구조적 문제 앞의 무력	건강 불평등이나 의료체계의 실패처럼 원인이 개인 행동 너머에 있는 문제에 개인 수준의 도구로 대응하면 문제 자체가 개인화된다. 학습자는 목격한 구조적 문제를 사고하고 발화할 개념적 통로를 갖지 못한다.

네 한계는 평가 영역에서도 같은 방향으로 나타난다. 본 과제가 검토한 문헌에서 전문직업성 평가는 개별 학습자의 관찰 가능한 행동과 태도를 확인하는 도구를 중심으로 축적되어 있으며, 전문직 집단의 집합적 책무나 구조적 차원에 대한 개입을 평가 대상으로 삼는 도구는 확인되지 않았다. 집단적·구조적 책무가 교육과정과 평가에 공식화되지 않으면, 학습자에게 남는 언어는 개별 진료의 언어에 한정된다.

중요한 것은 이 공백이 우연한 누락이 아니라 개인 수준 프레임의 논리적 귀결이라는 점이다. 따라서 필요한 것은 기존 전문직업성 교육에 덕목 하나를 더하는 일이 아니라, 전문직업성 개념 자체를 집단적·구조적 차원으로 확장하는 관점이다.

다. 본 과제가 해결하고자 한 문제

본 과제가 해결하고자 한 문제는 세 겹이다. 첫째, 시민성 교육이 의학교육 내부의 언어를 갖지 못한 상태를 해소하는 것이다. 시민성이 교양·선택과목의 주제로 다루어지는 동안 그것은 전문직업성 담론과 연결되지 않았고, 그 결과 의과대학이 시민성 교육을 자기 교육과정의 과제로 인식할 근거가 약했다. 둘째, 개념을 성과체계로 실물화하는 것이다. 관점만으로는 교육과정이 되지 않으므로, 영역과 졸업성과, 세부성과의 위계를 구성하고 이를 기존 성과체계와 매칭하여 대학이 곧바로 참조할 수 있는 형태로 만들어야 한다. 셋째, 성과체계를 실제 수업으로 옮길 교과 설계와 공유 콘텐츠를 산출하는 것이다.

요컨대 본 과제는 시민성 교육을 의학교육의 언어로 정립하고, 이를 성과체계와 공유 강의 모듈이라는 두 층의 산출물로 실물화하는 것을 1차년도의 과제로 설정하였다. 이 문제 설정은 개념 정립(학술논문), 성과체계 확정(영역·졸업성과·세부성과·KGO 매칭), 콘텐츠 개발(K-MedU 강의 모듈)이라는 본 보고서 IV장 이하의

추진 체계·실적 구성에 그대로 대응한다.

2. 주요 개념 및 용어 정의

본 과제가 사용한 핵심 용어를 정의한다. 정의는 본 과제의 학술논문(「의학교육에서 시민성 교육의 의미와 방향: 시민적 전문직업성의 관점에서」, 의학교육논단 KMER-26-015, 1차 리비전 준비 중)의 개념 검토를 따른다.

〈표〉 주요 용어 정의

용어	정의	출처
의학전문직업성(medical professionalism)	의료전문직과 사회 사이의 계약을 토대로, 환자 복지의 우선·환자 자율성 존중·사회정의라는 세 원칙과 이에 따르는 책무로 규정되는 전문직의 규범 체계	의사헌장(ABIM Foundation 등, 2002)
시민성(citizenship)	공동체 구성원이라는 지위와 그에 결부된 권리·의무, 그리고 공동체의 공적 사안에 참여하는 실천을 포괄하는 개념	본 과제 논문(KMER-26-015)
시스템 시민성(system citizenship)	개별 환자와 환자 집단, 보건의료시스템의 총체적 필요에 기여하여 최선의 결과를 달성하는 보건의료전문인의 역할 개념. 시스템 사고 전통에 뿌리를 둔다	Gonzalo 등(2023)
구조적 역량(structural competency)	건강 결과를 진료실 밖에서 규정하는 구조·제도·정책을 분석하고 그에 개입하는 역량	Metzl & Hansen(2014)
공적 이성(public reason)	서로 다른 신념을 가진 시민들이 공적 문제를 논의할 때 모두가 합리적으로 수용할 수 있는 이유를 제시해야 한다는 규범적 요청	Rawls(1997)
세부성과	본 과제 성과체계의 최하위 단위. 영역별 졸업성과 아래에 인지적·사회정서적·행동적 3영역으로 서술한 성과 단위를 둔다. 세부성과 1개를 25분 강의 모듈 1개에 대응시키는 것을 설계 원칙으로 두었다(영역을 두 개씩 묶어 교과목을 편성하는 과정에서 일부 세부성과가 모듈 단위로 병합되어, 본문 14모듈과 세부성과 18개의 1:1 대응은 확정되지 않았다)	본 과제 4차·7차 회의
KGO(기본의학교육 졸업성과)	KAMC가 제시한 기본의학교육 졸업성과. 제2판은 5개 영역 18개 성과로 구성된다. 본 과제는 세부성과와 KGO 2판을 매칭하였다	KAMC 기본의학교육 졸업성과 제2판

3. 선행연구 및 문헌 고찰

가. 문헌 검토 방법 및 범위

본 과제의 문헌 검토는 체계적 문헌고찰이 아닌 서술적 고찰(narrative review)로 수행하였다. 검토 대상은 세 갈래다. 첫째, 2002년 의사헌장 이후 의학전문직업성의 개념·교육·평가를 다룬 국외 문헌이다. 둘째, 시민적 전문직업성의 계보를 이루는 주요 문헌이다. 셋째, 한국 의학교육의 현황과 제도를 다룬 국내 문헌이다.

문헌은 세 기준에 따라 선별하였다. 개념 전개의 주요 논의인지, 교육과 평가에 관한 실증적 근거를 제공하는지, 한국 맥락에 적용 가능한지가 그 기준이다. 논의의 범위는 기본의학교육(학부)을 중심으로 하되 개념 논의에서는 졸업후교육 맥락의 문헌을 포함하였다. 최종 검토 문헌은 59편이며, 검토 결과는 학술논문으로 정리하여 의학교육논단에 투고하였다(KMER-26-015, 수정 통보 후 1차 리비전 준비 중).

나. 주요 이론·모형

둘째, 시민성 개념에는 전문직업성의 재조명에 필요한 두 특질이 있다. 하나는 역사적 확장성이다. 시민성은 고정된 권리의 목록이 아니라 공동체의 요구에 따라 확장되어 온 역사적 구성물이며, 시민적 지위의 내용은 공민적 권리에서 정치적 권리, 사회적 권리로 넓어져 왔다. 이 확장은 국민국가의 경계에 머물지 않고 인류 공동체의 구성원이라는 지위와 책임을 포괄하는 세계시민성으로 이어졌다. 다른 하나는 공적 실천성이다. 현대 시민성 논의의 중심은 지위로서의 시민에서 실천으로서의 시민, 곧 공공선을 둘러싼 숙의와 참여의 양식으로 이동해 왔으며, Rawls가 정식화한 공적 이성이 그 규범적 핵심을 이룬다.

셋째, 시민적 전문직업성은 새로 창안된 개념이 아니라 20년 이상 축적된 계보를 지닌 개념이다. 계보의 기점에서 Sullivan은 기술적 전문성으로 축소된 전문직업성을 비판하며 전문가의 통합성에 공적 목적에 대한 헌신이 포함되어야 한다고 주장하였고, 의료전문직의 위기가 전문 지식의 부족이 아니라 전문직과 사회를 잇는 시민적 결속의 약화에서 온다고 진단하였다. Larson은 이를 의학에 직접 적용하여, 의사가 전문 지식을 사적으로 판매하는 지식노동자에 머물러서는 안 되며 자신의 전문성을 공공선을 위해 사용하는 시민적 전문가가 되어야 한다고 논증하였다. 같은 시기 카네기재단의 의학교육 개혁 보고서(Cooke 등, 2010)는 의사를 전문직과 공동체에 참여하는 시민(engaged citizens)으로 규정하고, 지역사회와 전문직에 관여하는 의사-시민(physician-citizen)의 양성을 교육 목표로 명시하였다. 이 계보는 전문직업성 담론의 주류와 별개로 흐른 것이 아니라 그 내부의 전개와 합류한다.

넷째, 두 담론의 수렴을 차원별로 정리한 것이 아래의 「의학전문직업성의 시민적 확장 비교표」다. 첫째 열과 둘째 열은 기존 전문직업성이 의사헌장의 출발 프레임에서 이후 20년의 내적 전개로 나아간 궤적을 보이며, 셋째 열은 그 전개에 시민성의 결합이 더하는 차원을 담는다. 시민적 전문직업성은 기존 전문직업성을 부정하거나 대체하는 것이 아니라 그 내적 전개를 민주사회의 맥락으로 넓히는 확장이다.

〈표〉 의학전문직업성의 시민적 확장 비교표 (7개 차원)

차원	출발 프레임(2002 의사헌장)	이후 내적 전개	시민적 전통이 더하는 것
책무의 주체	개별 의사	+ 전문직 집단과 의료조직	+ 민주사회의 시민적 행위자로서의 전문직
책임의 범위	환자-의사 관계	+ 의료시스템(시스템 시민)	+ 공동체와 사회 전체, 공공선(지역~지구)
사회문제에 대한 개입	개인의 태도·행동규범	+ 의료시스템 내 개선 활동	+ 구조적 역량과 사회적 옹호
정당화 양식 *	환자·동료에 대한 설명책임	+ 정부·조직에 대한 성과·비용효과 책임	+ 공적 이성애 근거한 정당화 책임
지식의 성격	전문지식 독점에 근거한 권위	+ 팀 기반 진료 참여를 통한 전문성 행사	+ 민주적으로 공유되는 공공재로서의 지식
교육의 초점	역량과 행동의 습득(doing)	+ 전문직 정체성 형성(being)	+ 정체성 형성에 시민적 정체성 통합

여섯째, 이 확장을 전문직 정체성 형성의 틀 안에서 도식화한 것이 3층위 형성 모델이다. 세 층위는 순차적 단계가 아니라 사회적 범위가 확장되는 동심원이며, 모든 층위의 형성은 잠재교육과정과 권력관계라는 맥락 조건 속에서 이루어진다. 이 모델은 시민적 전문직업성이 별도 교과가 아니라 정체성 형성 교육 전체의 사회적 층위로 설계되어야 함을 함의한다.

〈표〉 시민적 전문직업성 형성 모델의 3층위

층위	형성 내용	교육 전략	평가
개인(personal)	시민성 개념 이해, 공동체 구성원으로서의 자기 위치 확인, 성찰을 통한 전문직 규범과의 통합	개념 학습, 성찰	성찰 기록
집단(collective)	실천공동체 참여와 집단 소속 경험을 통한 전문직의 집합적 정체성 형성	실천공동체 경험	실천공동체 내 다면평가
사회(societal)	구조적 역량 학습, 지역사회 참여, 공적 정당화를 통한 시민적 정체성의 통합	지역사회 참여, 공적 정당화	지역사회 파트너 관찰, 공적 정당화 능력 확인

일곱째, 이 모델을 구현할 교육 전략으로 다섯 가지를 검토하였다. 건강 결과를 진료실 밖에서 규정하는 구조·제도·정책을 분석하는 구조적 역량 교육, 단발성 견학이 아니라 교수 멘토십과 지역 파트너 참여를 결합한 지속적 관계로서의 지역사회 기반 학습, 의정갈등 맥락에서 공공선 옹호와 직역 이익 옹호를 가르는 기준으로 공적 이성을 활용하는 옹호 교육, 정책 브리프 작성과 모의 공청회를 통한 숙의 학습, 그리고 이들을 조직하는 3층위 형성 모델이다. 평가 전략은 단기와 장기로 구분하였다. 단기적으로는 검증된 전문직업성 평가 청사진에 시민적 차원의 관찰 지표를 더하고 국내 의과대학이 이미 도입하였으나 저활용 상태인 포트폴리오를 활용하며, 장기적으로는 국내 전문직업성 척도 개발·타당화 경험과 시민교육 분야의 평가 틀을 두 축으로 삼아 전용 평가도구를 개발한다.

다. 국내 연구 동향

국내 전문직업성 교육의 현황은 국외 구도와 크게 다르지 않다. 국내 의과대학의 전문직업성 교육과정에서 전문직 정체성 형성 교육의 현황을 검토한 연구(참고문헌 8)는 교육이 강의와 토론에 편중되고 성찰적 글쓰기와 피드백은 저활용되며 학교 간 편차가 크다는 점을 보고하면서, 전문직 정체성 형성을 학습성과로 명시하고 전 학년에 걸쳐 배치할 것을 제안하였다. 이는 잠재교육과정의 지배라는 앞의 한계가 한국에서도 작동함을 시사한다.

사회적 책무성 논의는 국내에서 개념과 실천전략 수준까지 정립되어 있다(참고문헌 10). 아울러 기본의학교육 인증기준의 사회적 책무성 반영 정도를 분석한 연구(참고문헌 9)는 상당수 항목이 사회적 책무성을 반영하고 있음을 확인하였다. 평가 영역에서는 국내에서 전문직업성 척도를 개발·타당화한 경험이 축적되어 있으며, 이는 향후 시민적 전문직업성 평가도구 개발의 방법론적 기반이 된다.

학습자 측면의 조건도 변화하고 있다. 의과대학생 다수가 사회참여 역량을 기르는 방향의 교육 변화에 공감한다는 조사 결과가 있으며, 초·중등학교의 2022 개정 교육과정이 민주시민 교육을 강조함에 따라 앞으로 입학할 학습자는 시민성 교육을 이미 경험한 세대다. 의학교육이 이 경험을 이어받지 못하면 시민적 역량의 형성은 의과대학 입학과 함께 단절된다. 다만 시민성 지향 교육의 효과를 통제된 설계로 확인한 국내 연구는 본 과제의 검토 범위에서 확인되지 않았으며, 효과 근거의 확보는 후속 과제로 남는다.

라. 선행연구의 한계와 본 과제의 차별성

선행연구의 한계는 두 가지로 정리된다. 첫째, 국내에서 시민성 교육은 주로 교양·선택과목의 주제로 다루어져 왔고 의학전문직업성 담론과 연결되지 않았다. 그 결과 시민성 교육은 의학교육 안에서 부가적 활동으로 인식되었고, 의과대학이 이를 자기 교육과정의 성과로 편입할 근거가 형성되지 않았다. 둘째, 시민성 교육의 효과에 관한 실증 근거가 축적되어 있지 않다. 본 과제의 검토 범위에서 통제집단을 둔 설계나 중단 설계로 효과를 확인한 연구는 확인되지 않았으며, 이는 시민성 교육의 효과가 설계와 운영 조건에 좌우될 가능성을 남긴다.

본 과제의 차별성은 새로운 개념의 창안이 아니라 수렴 지점의 식별과 정식화, 그리고 구현이다. 첫째, 전문직업성 담론과 시민성 담론이 각각의 전개 속에서 수렴하고 있음을 식별하였다. 둘째, 그 수렴을 시민적 전문직업성으로 정식화하고, 기존 전문직업성과의 차별적 속성을 「의학전문직업성의 시민적 확장 비교표」로 정리하였다. 셋째, 이를 한국 의학교육의 교육과정·교수학습·평가 전략으로 구체화하였다. 특히 셋째 지점에서 본 과제는 논문의 개념적 제안을 6개 영역·졸업성과·세부성과의 성과체계와 KGO 2판 매칭, K-MedU 공유 강의 모듈이라는 실물 산출물로 옮겼다. 개념 검토에 그치지 않고 대학이 참조할 수 있는 형태까지 도달

한 점이 선행 논의와의 차이이다.

한편 본 절의 이론적 검토에도 한계가 있다. 이 검토는 서술적 고찰에 기반한 개념적 정리이며, 제시한 형성 모델과 교육 전략은 확립된 근거의 요약이 아니라 검증되어야 할 제안이다. 시민적 경험이 정체성 형성의 기제로 작동하는 과정에 대한 통제된 종단 연구, 평가도구의 개발과 타당화, 한국 의과대학 맥락의 구현 연구가 남은 과제다. 본 과제는 이 한계를 인식한 상태에서 성과체계와 콘텐츠를 산출하였으며, 효과 검증은 2차년도 이후의 과제로 이월하였다.

4. 국내외 사례 분석

문헌 검토와 병행하여 시민성 교육 및 그 인접 교육의 국내외 운영 사례를 검토하였다. 검토의 목적은 우수 사례의 소개가 아니라 본 과제의 성과체계와 교과 설계에 반영할 설계 원리를 추출하는 데 있었다. 아래 표의 시사점은 각 사례가 본 과제의 어느 설계 결정에 반영되었는지를 함께 기술하였다.

〈표〉 국내외 사례 분석

구분	기관·대학(국가)	주요 운영 내용	시사점 및 본 과제 반영
국외	구조적 역량 교육과정(미국, Neff 등, MedEdPORTAL 2020)	의과대학생·전공의·보건의로 팀을 대상으로 건강격차를 만드는 구조적 요인을 다루는 3개 모듈. 강의와 소그룹 사례 토론으로 구현. 학습자 관점이 환자를 비난하는 관점에서 구조를 이해하는 관점으로 이동하였음을 보고	구조 분석이 짧은 모듈 단위로도 구현 가능함을 확인. 세부성과의 인지적 영역에 구조·제도 분석을 명시하고, 25분 단위 모듈 설계의 원형으로 참조. 아울러 지역사회 기반 학습은 단발성 견학이 아니라 교수 멘토십과 지역 파트너 참여를 결합한 지속적 관계로 설계한다는 원칙을 채택
국외	카네기재단 의학교육 개혁 보고서(미국, Cooke 등, 2010)	의학교육 개혁의 축으로 의사-시민(physician-citizen)의 양성을 제시하고, 의사를 전문직과 공동체에 참여하는 시민으로 규정하였다	시민성을 별도 교과목의 주제가 아니라 정체성 형성 교육의 목표로 설정. 교과 편성을 신설이 아닌 기존 교과 재설계 방식으로 접근하는 근거
국외	UNESCO 세계시민교육 학습성과 체계 (2015)	세계시민교육의 학습성과를 인지·사회정서·행동의 세 영역으로 구조화하여 시민성의 평가 대상을 명세	세부성과 서술 방식을 KSA 단일 태깅에서 3영역 서술로 전환하는 근거(7차 회의). 장기 평가도구 개발의 참조 틀로도 활용
국내	서울대학교 의과대학 「사회와 의료현장의 리빙랩」	지역사회 기관과 연계한 실천형 교과로 4년간 운영. 학생·당사자·현장 담당자의 사례를 함께 다룸	지역사회 기반 학습의 국내 운영 사례이자 지속적 관계 설계의 실물 근거. 「우리 지역사회와 함께하는 리빙랩」 강의 모듈로 편성하여 공유 콘텐츠에 편입
국내	초·중등 2022 개정 교육과정 및 한국교육과정평가원 민주시민성 지표(교육부, 2022)	총론에서 민주시민 교육을 강조. 한국교육과정평가원은 학교 수준 민주시민교육을 위한 민주시민성 6대 지표를 제시	향후 입학생이 시민성 교육을 경험한 세대라는 전제 확인. 민주시민성 6대 지표를 의학교육 맥락으로 재구성하여 본 과제 6개 영역을 도출

5. 시사점 및 과제 설계 방향

문헌 고찰과 사례 분석에서 도출된 시사점은 다섯 가지이며, 각 시사점은 1차년도의 특정 설계 결정으로 이어졌다. 시사점과 반영 내용의 대응은 아래와 같다.

〈표〉 시사점과 과제 설계 반영

도출된 시사점	과제 설계 반영 내용
시민성은 별도 교과가 아니라 정체성 형성 교육의 사회적 층위여야 한다	교과 편성을 신설 교과가 아니라 기존 전문직업성 관련 교과의 재설계 방식으로 접근
개인 수준 프레임으로는 구조적 문제를 다룰 수 없다	세부성과에 구조·제도 분석과 공적 참여의 차원을 포함. 인지적 영역에 사회구조와 건강 형평성의 분석을, 행동적 영역에 정책 수립·사회적 소통 참여를 명시
세부성과는 KSA 단일 태깅으로 담기지 않는다	7차 회의에서 세부성과 서술을 지식·술기·태도 태깅에서 인지적·사회정서적·행동적 3영역 서술로 전환. UNESCO 세계시민교육의 학습성과 3영역 구조를 채택
기존 성과체계와 인증기준이 제도적 근거를 이미 제공한다	KGO 2판과의 매칭을 성과체계 설계의 필수 절차로 편입. KGO 2판 18개 졸업성과 중 10개가 시민성 교육 영역과 대응하며, 대응이 「소통과 협력」·「사회적 책무성」·「전문직업성」 영역에 집중됨을 확인
모듈 조합의 유연성이 대학 자율성을 좌우한다	세부성과 1개를 25분 단위 모듈 1개에 대응시키는 것을 최소 단위 설계 원칙으로 설정. 대학이 2~3개 모듈로 1시간, 4~5개 모듈로 2시간 수업을 구성할 수 있도록 설계

이 다섯 가지 설계 방향은 Ⅲ장의 추진 목표 및 성과지표, V장 이하의 세부 추진 실적에 그대로 반영되었다. 특히 개념 정립(논문)과 성과체계(영역·졸업성과·세부성과-KGO 매칭), 공유 콘텐츠(K-MedU 강의 모듈)의 세 층이 서로 독립된 산출물이 아니라 하나의 논증 라인 위에 놓이도록 구성한 점이 1차년도 설계의 핵심이다.

02 과제 목표 및 성과지표

1. 최종 목표 및 1차년도 목표

본 과제는 의학전문직업성을 민주사회의 시민적 차원으로 확장하여, 의과대학이 시민성 교육을 실제 교육과정으로 운영할 수 있도록 성과체계·교과 설계·공유 강의 모듈을 개발하는 것을 목적으로 한다. 1차년도는 개념 정립과 성과체계 확정을 우선 과제로 설정하고, 확정된 성과체계에 근거하여 교과 설계와 1개 영역의 강의 모듈 개발까지 도달하는 것을 범위로 삼았다.

〈표〉 과제 목표

구 분	내 용
최종 목표(사업 종료 시점)	전국 의과대학이 자교 교육과정에 적용할 수 있는 시민성 교육과정 패키지를 완성한다. 패키지는 ① 시민성 교육 성과체계(영역·졸업성과·세부성과 및 기본의학교육 졸업성과(KGO) 연계), ② 시그니처 교과목 가이드북(2차년도 개발), ③ 공유대학(K-MedU) 강의 모듈, ④ 시민적 전문직업성 평가 도구의 네 가지 구성요소로 이루어진다.
1차년도 목표	① 시민성 교육의 개념적 토대를 의학교육 담론 내부의 언어로 정립하고 학술논문으로 정식화한다. ② 6개 영역·졸업성과·세부성과로 구성된 성과체계를 확정하고 KGO 2판과 매칭한다. ③ 1개 영역의 K-MedU 공유 강의 모듈을 개발한다.
과제 범위(포함·제외)	포함: 기본의학교육(의학전·임상실습전·임상실습) 단계의 시민성 교육 성과체계 설계, 공유 강의 모듈 개발, 개념적 기반에 관한 학술적 정식화제외: 졸업후교육(전공의) 단계의 교육과정, 교과목 편성안(시그니처 교과목) 확정, 평가도구의 개발 및 타당화, 시범운영을 통한 교육 효과 검증 — 네 항목은 성과체계 확정을 선행 조건으로 하므로 2차년도 이후 과제로 이월하였다.

2. 성과지표 및 목표치

본 과제의 성과지표는 KAMC 「의학교육혁신 사업관리 핵심성과지표(안)」(2025.10)에 제시된 전략목표 G4 「시민성(Citizenship) 중심 교육과정 개발 및 적용」의 핵심성과지표(KPI)를 따른다. 해당 지표 체계에서 본 과제의 핵심성공요인(CSF)은 「교육과정의 시각화 및 학습자료 제작, 지속 가능한 환류체계 구축」이며, 관리 책임은 이승희·김강철로 지정되어 있다. 1차년도(Y1)에 배정된 지표는 5개이고 모두 산출물의 완료 여부로 판정하는 여부(Y/N) 지표이다.

〈표〉 성과지표 및 달성 실적 (KAMC 핵심성과지표 G4, Y1)

연번	성과지표명	유형	산출식·측정 방법	목표	실적	달성률(%)
1	시민성 중심 의학교육과정(안) 개발 완료	정성	시민성 함양을 위한 의학교육과정(교육목표·내용·방법·평가 포함) 개발 및 문서화 여부	Y	6개 영역·6개 졸업성과·18개 세부성과 체계, KGO 2판 매칭(안), 통합 구조표, K-MedU 통합 강의계획서 문서화 완료	100
2	시민성 교육 동영상 콘텐츠 제작 완료	정성	개발된 교육과정을 기반으로 한 교육용 동영상 제작 완료 여부	Y	강의자 5명·25분 기준 12회분 강의계획서 확정, 촬영 순차 진행 중	종료 시점 확정
3	시민성 교육 동영상 공유대학 탑재	정성	시민성 교육 동영상 공유대학(K-MedU) 탑재 여부	Y	K-MedU 과정 개설신청서·모듈계획서 작성 완료, 촬영본 탑재 대기	종료 시점 확정
4	시민성 기반 의학교육 논문 작성 및 투고	정성	시민성을 기반으로 한 Medical Professionalism 관련 논문 초안 작성·투고 여부	Y	의학교육논단 투고(KMER-26-015), 수정 통보 후 1차 리비전 준비 중	100
5	교육과정 및 연구성과 확산 활동 수행	정성	개발된 교육과정 및 논문·영상 성과를 학회·정책 회의·교육기관 등에 공유·확산 여부	Y	KAMC Annual Meeting 구연 발표(2025.11.14)	100

지표 1·4·5는 1차년도에 달성하였고, 지표 2·3은 강의계획서 확정까지 완료한 뒤 촬영과 플랫폼 탑재가 순차 진행 중이므로 1차년도 종료 시점(2026. 8. 31.)에 달성 여부가 확정된다.

한편 동일 지표 체계에서 2차년도(Y2)에 배정된 지표는 「공유대학 탑재한 시민성 교육 동영상 보완 및 확산 여부」 1개이며, 이는 1차년도 지표 2·3의 결과를 승계하는 구조이다. 연차 성격은 Y1부터 Y3까지가 설계 및 제도화 단계, Y4부터 Y5까지가 고도화 단계로 구분되어 있어, 1차년도는 설계 및 제도화 단계의 첫 해에 해당한다.

03 추진 체계 및 방법

1. 추진 체계 및 조직

본 과제는 KAMC 주도 과제로서, 과제책임자와 간사를 포함한 11명의 연구회의(TF)를 의사결정 단위로 두고 운영하였다. 연구회의는 성과체계의 설계와 심의를 담당하며 월 1회 개최를 원칙으로 하였다. 실무진은 과제책임자와 간사 2명으로 구성하여 회의 안건 자료 작성, 회의 결과 정리, 산출물 문서화를 수행하였다. 위원 구성은 의학교육학·의학사·가정의학·치의학교육·교육학으로 전공을 분산하여, 시민성 교육을 의학교육 내부의 언어로 번역하는 과정과 일반 교육학의 시민교육 논의를 함께 검토할 수 있도록 하였다.

강의 모듈 개발 단계에서는 TF 위원 외에 해당 주제의 교육 경험을 보유한 외부 강일자 2명을 협력자로 참여시켰다. 또한 개발 모듈의 탑재를 위해 KAMC 공유대학(K-MedU) 담당 부서와 협의하여 콘텐츠 제작 절차 및 서식을 확인하였고, 의료시스템과학(HSS) 과제 및 디지털 전환 과제와는 주제 중복 회피를 위한 협의를 진행하였다.

〈표〉 추진 조직

조직·회의체	구성(인원)	주요 기능 및 개최 주기
과제 연구회의(TF)	11명 (과제책임자 1, 공동연구원 9, 간사 1)	성과체계 설계·심의, 영역 및 졸업성과·세부성과 확정, KGO 매칭 심의, 콘텐츠 개발 범위 결정. 월 1회 개최 원칙
실무진	2명 (과제책임자, 간사)	회의 안건 자료 작성, 회의 준비 및 결과 정리, 산출물 문서화, 논문 집필 및 보고서 작성. 수시
전체 워크숍	11명 (TF 전원)	위원별 전문 관점 발표 및 공유, 타 교육단계 시민성 교육과정과의 접점 검토. 연 1회
외부 강일자 협력	2명 (손호준, 오주환)	K-MedU 강의 모듈의 주제 설계 및 강의 개발. 수시

2. 참여 대학·기관 현황

〈표〉 참여 대학·기관

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
1	서울대학교 의과대학	공동개발	이승희, 김강철	과제 총괄 및 실무. 외부 강이자 2명(손호준, 오주환)의 강의 모듈 2종 제공, 리빙랩 사례 제공
2	인하대학교 의과대학	공동개발	김근호	이론적 기반 검토, 학술논문 공동집필
3	아주대학교 의과대학	공동개발·콘텐츠 제공	김신권	시민성·전문직업성 개념 검토, 강의 모듈 1종 개발. 개론 성격 모듈은 자체 제작
4	원광대학교 의과대학	공동연구	김영전	지역사회·일차의료 관점의 성과체계 검토
5	서울대학교 치의학대학원	공동개발·콘텐츠 제공	박보영	건강형평성·의료데이터 관점 검토, 강의 모듈 1종 개발
6	연세대학교	공동연구	박수연	시민교육 이론 및 학교 시민교육 교육과정 검토
7	한국방송통신대학교	공동개발·콘텐츠 제공	이로미	다양성 교육 관점 검토, 강의 모듈 1종 개발
8	충남대학교 의과대학	공동연구	김정란	정신의학 관점의 성과체계 검토
9	조선대학교 의과대학	공동연구	하정민	성과체계 검토, 학술대회 발표 공동저자
10	울산대학교 의과대학	공동연구	이경도	인문사회의학 관점의 성과체계 검토

3. 연구·개발 방법

1차년도는 개념 정립과 성과체계 확정을 목표로 하였으므로, 방법은 문헌고찰과 전문가 합의 두 축으로 구성하였다. 문헌고찰은 학술논문의 논증 근거와 본 보고서 이론적 배경의 근거로 사용하였고, 전문가 합의는 영역·졸업성과·세부성과의 확정과 교과 설계 결정에 사용하였다.

〈표〉 연구·개발 방법

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
문헌고찰	2002년 의사현장 이후 전문직업성 개념·교육·평가 문헌, 시민적 전문직업성 계보 문헌, 한국 의학교육 현황 문헌 (59편)	2025.7~2026.7	서술적 고찰(narrative review). 개념 전개·교육 근거·한국 적용 가능성의 3기준으로 선별. 학술논문 및 본 보고서 표장의 근거로 활용
워크숍·합의회의	TF 위원 11명	2025.7~2026.4 (8회)	전문가 합의(consensus) 방식. 회차별 안건 자료를 사전 배포하고 논의 결과를 다음 회차에 재확인하는 절차로 6개 영역·졸업성과·세부성과를 확정하고 KGO 매칭(안)을 도출
기타(콘텐츠 개발)	강의 모듈 5종 12회분	2026.4~2026.8	강의계획서(개설신청서·모듈계획서) 작성 → 영상 제작 → K-MedU 탑재의 순서로 진행. 25분 단위 모듈을 최소 단위로 설계하여 대학별 조합 운영이 가능하도록 구성

4. 연구윤리

〈표〉 연구윤리

구 분	내 용
IRB 심의 여부	☐ 승인 ☐ 심의면제 ☒ 해당없음 — 인간 대상 연구를 수행하지 않았다. 1차년도 연구·개발은 문헌고찰과 연구진 내부의 전문가 합의를 기반으로 하였으며, 학습자·교수자를 대상으로 한 자료 수집은 이루어지지 않았다
개인정보 보호 조치	회의 참석자 명단 등 개인정보가 포함된 자료는 사업 목적 범위에서만 관리하며, 보고서 및 산출물에는 비식별 처리하여 수록하였다
저작권·초상권 확인	개발 강의 모듈의 저작권 귀속은 KAMC와 강의자 간 합의에 따르며, 인용 문헌은 Vancouver 양식으로 출처를 명시하였다.

5. 추진 일정

〈표〉 단계별 추진 일정

단계	기간	주요 활동	단계별 산출물
1단계개념 정립	2025.7~9	kick-off 회의(7.26)로 TF 구성 및 사업 범위 확정, 전체 워크숍(8.30)에서 위원별 전문 관점 공유, 3차 회의(9.27)에서 연구질문 확정	「의학교육에서 시민성 교육방향 제언」 초안(6장 구성), 「초·중·고 시민성 교육과정 현황 분석」, 연구질문 3개
2단계성과체계 설계	2025.10~12	4차 회의(10.16)에서 설계 템플릿 확정, KAMC Annual Meeting 중간발표(11.14), 5차 회의(12.29)에서 논문과 성과체계의 이론적 정합성 검토	「시민성 교육과정 설계 템플릿 v1.0」, 학술대회 구연 발표 1건, 학술논문 초고
3단계성과체계 확정	2026.1~2	6차 회의(2.3)에서 영역 및 졸업성과 심의·확정, 중분류(역량) 용어를 졸업성과 문장에 흡수하는 방식 합의	6개 영역 및 졸업성과 6개 확정본, 학술논문 v2.0
4단계교과·콘텐츠 설계	2026.3~4	7차 회의(4.20)에서 세부성과 도출·KGO 2판 매칭·1차 콘텐츠 대상 영역 확정, 후속 운영회의(4.21)에서 서술 방식 및 모듈 배정 정리	세부성과 18개, 시민성 영역·세부성과-KGO 2판 매칭표, 시민성 교육과정 통합 구조표, K-MedU 통합 강의계획서(개설신청서+모듈계획서)
5단계콘텐츠 제작·정리	2026.5~8	영상 제작 업체 계약 및 강의자별 촬영 조율, 강의 모듈 순차 제작·탑재, 학술논문 1차 리비전 준비, 1차년도 결과 정리	강의 모듈 5종 12회분(제작·탑재 진행 중), 학술논문 1차 리비전 원고(준비 중), 1차년도 최종보고서

04 추진 경과 및 실적

1. 단계별 추진 경과

본 과제의 1차년도 추진 경과를 다섯 단계로 구분하여 서술한다. 단계별 확정 사항은 다음 단계의 전제가 되어 개념 정립에서 강의 모듈 제작까지 하나의 결정 계열을 이룬다.

가. 1단계: 개념 정립 (2025.7~9)

1단계의 쟁점은 시민성을 의학교육에서 어떤 언어로 정립할 것인가였다. 시민성은 교육학과 정치철학에서 축적된 개념이므로 그 언어를 그대로 옮기면 의학교육 담론 안에서 근거를 확보하기 어렵고, 반대로 기존 의료윤리 교육의 하위 주제로 배치하면 별도 과제로 개발할 이유가 약해진다. 따라서 기존 교육과의 차별점을 개념 수준에서 규명하는 일이 성과체계 설계보다 먼저 해결되어야 할 과제였다.

2025년 7월 26일 킥오프 회의에서 TF 위원 구성과 사업 범위·목표를 확정하고, SDGs 4.7, UNESCO 세계시민교육(GCED), RALE, GRALE 5, Reimagining Our Futures 등 국제 정책 흐름과의 정합성을 검토하였다. 이 검토는 시민성 교육이 국제 교육 의제로 이미 확립되어 있음을 확인하는 근거가 되었으며, 동시에 월 1회 정기회의 운영을 합의하여 이후 의사결정의 주기를 정하였다.

2025년 8월 30일 2차 회의(워크숍)에서는 위원별 전문 관점을 공유하였다. 김신권 「선한 사람들이 나쁜 사회를 만드는 이유」, 박보영 「세계시민의 자질: 평화와 비폭력」, 이로미 「노인이주민 프로그램 개발」 발표를 통해 의학사, 건강형평성, 다양성 교육의 관점을 병렬로 검토하고, 2022 개정 교육과정과 시민성 교육의 접점을 확인하였다.

2025년 9월 27일 3차 회의에서 「의학교육에서 시민성 교육방향 제언」 초안(6장 구성)을 검토하고 「초·중·고 시민성 교육과정 현황 분석」을 보고하여 연구질문을 확정하였다. 이 과정에서 시민성을 기존 교과목의 새로운 주제로 추가하는 것이 아니라 전문직 정체성의 핵심 차원으로 재정의하는 방향에 합의하였다. 이 합의는 이후 성과체계 설계와 학술논문 논지의 공통 전제가 되었다.

나. 2단계: 성과체계 설계 (2025.10~12)

2단계의 쟁점은 성과체계의 층위를 어떻게 구성하고 어떤 기존 체계를 준용할 것인가였다. 시민성은 포괄 범위가 넓어 영역 설정이 임의적으로 보일 위험이 있고, 국내 의과대학이 사용하지 않는 형식으로 독자 설계하면 대학이 기존 교육과정에 접합하기 어렵다는 문제가 함께 제기되었다.

2025년 10월 16일 4차 회의에서 「시민성 교육과정 설계 템플릿 v1.0」을 확정하고, 영역에서 졸업성과, 학습성과, 세부학습성과로 내려가는 층위 체계에 합의하였다. 동시에 「융합형 기초의학 교과목 가이드북」(대한기초의학협의회·대한의학회, 2023)의 교과목별 9개 항목 구조를 준용하기로 결정하였다. 이는 국내 의과대학이 이미 사용하는 교과목 서술 형식을 채택하여 도입 부담을 낮추는 선택이었다.

2025년 12월 29일 5차 회의에서는 시민성 논문 v1.1을 검토하고, AAMC FRAHME 프리즘 모델과 KAMC 학습성과의 융합 적용 방안을 검토하였다. 이론적 근거와 국내 성과체계를 동시에 충족시키는 서술 방식을 찾는 작업이었다.

2단계에서 확정된 사항은 영역에서 졸업성과, 세부성과로 이어지는 층위 구조와 교과목 가이드북 9개 항목의 준용이다. 다만 학습성과 단위의 세분화는 이 단계에서 결론에 이르지 못하고 세부성과 수준에서 정리되었다.

다. 3단계: 성과체계 확정 (2026.1~2)

3단계의 쟁점은 중분류에 해당하는 역량 용어를 성과체계에 명시할 것인가였다. 「사회적 책무성」이나 「협력적·민주적 리더십」과 같은 용어는 국내 의학교육 담론에서 이미 다른 용법으로 사용되고 있어, 이를 별도 계층으로 표기하면 기존 논의와 충돌하거나 특정 입장으로 읽힐 우려가 제기되었다. 반대로 역량 층위를 삭제하면 영역과 졸업성과 사이의 연결 논리가 드러나지 않는다는 문제가 있었다.

2026년 2월 3일 6차 회의에서 영역별 졸업성과 문구를 축조 심의하였다. 논문 v2.0을 병행 검토하여 개념 정의와 성과 문구가 서로를 지지하는지 확인하였다.

라. 4단계: 교과·콘텐츠 설계 (2026.3~4)

4단계에서는 두 가지 쟁점이 제기되었다. 첫째는 세부성과를 KSA(지식·술기·태도)로 단일 태깅할 수 있는가였다. 시민성 영역에서는 하나의 성과 안에서 지식·술기·태도가 분리되지 않고 함께 작동하며, 특정 성과를 지식(K)으로 규정하면 교수자가 지식 전달만 하면 된다고 오해할 위험이 있다는 지적이 있었다. 이에 대해 UNESCO 세계시민교육의 학습성과 3영역(인지적·사회정서적·행동적) 서술 방식으로 전환하기로 합의하였다. 각 영역마다 3영역을 모두 서술하므로 영역당 3개, 총 18개의 세부성과가 도출된다.

둘째는 1차년도에 6개 영역 전체의 콘텐츠를 개발할 수 있는가였다. 시간과 인력의 제약이 있고, 일부 영역은 의료윤리·의사소통 등 인접 학회의 활동과 중복될 우려가 확인되었다. 이에 영역 3(문화적 다양성과 공존)을 1차년도 우선 개발 대상으로 선정하고 나머지 영역은 2차년도로 이월하기로 합의하였다. 영역 3은 인접 학회 활동과의 중복이 적고, 다양성 교육과 건강형평성 등 연구진의 담당 전문 영역과 직접 연결된다는 점이 선정 근거가 되었다.

2026년 4월 20일 7차 회의에서 세부성과 18개를 도출하고 KGO 2판과의 매칭(안)을 도출하였다. KGO 2판 졸업성과 18개 중 고유 10개가 대응 관계를 가지며(하나의 KGO가 복수 영역에 대응하여 영역별 대응 건수는 17건), 대응이 「소통과 협력」·「사회적 책무성」·「전문직업성」 영역에 집중되어 시민성 교육과정이 이들 영역의 심화·확장 역할을 담당하는 구조로 정리되었다. 아울러 1차 콘텐츠 개발 대상을 영역 3 「문화적 다양성과 공존」으로 선정하고 강의 모듈별 강사와 시수를 확정하였다. 교과목 편성안은 회의 안건으로 검토하였으나 1차년도 사업 범위에서 제외하여 확정하지 않았다.

익일인 2026년 4월 21일 후속 운영회의에서 세부성과 서술 방식(3영역)을 확정하고, 산출물을 통합 구조표 하나로 단일화하며, 모듈 제목과 강사 배정을 확정하였다. 개론 성격 모듈은 별도 제작하는 방안을 협의하였다.

마. 5단계: 콘텐츠 제작 및 정리 (2026.5~8)

4단계에서 확정된 모듈 구성에 따라 K-MedU 통합 강의계획서(개설신청서 및 모듈계획서)를 2026년 4월에 작성 완료하고, 이후 영상 제작 업체 계약과 강의자별 촬영 조율을 진행하였다. 촬영과 플랫폼 탑재는 1차년도 종료 시점까지 순차 진행 중이며, 완료 편수는 종료 시점을 기준으로 확정한다.

이 단계에서는 KAMC 주도 콘텐츠와 개별대학 제작 콘텐츠의 절차가 문서화된 프로토콜로 정비되어 있지 않아, 공유교육과정팀과 협의하여 샘플을 먼저 제작하고 승인받는 방식으로 진행하였다.

학술논문은 의학교육논단(KMER)에 투고하여 수정 통보를 받았으며, 현재 1차 리비전 원고를 준비 중이다(원고번호 KMER-26-015).

논문은 심사 결과 수정 통보를 받았다. 편집위원과 심사위원의 공통 지적은 전문직업성 교육의 현황 분석이 부족하다는 것이었다. 이에 연구진 협의를 거쳐 원원고의 구조를 유지하되 전문직업성 담론과 시민성 담론이 수렴하고 있음을 논증하는 부분을 보강하고, 여섯 영역 서술은 원고에 유지하는 방향으로 수정 방향을 확정하였다. 성과체계의 이론적 근거는 이 수렴 논증에 놓인다.

2. 회의·워크숍·세미나 개최 실적

가. 개최 실적 총괄

〈표〉 개최 실적 총괄

전체 워크숍	1회	8	위원별 전문 관점 공유 및 이론적 기반 검토	2차 회의(2025.8.30)
연구회의(전문가 회의)	6회	46	개념 정립, 성과체계 설계·확정, 교과·콘텐츠 설계	1차 7명, 3차 8명, 4차 8명, 5차 10명, 6차 7명, 7차 6명
실무진 회의	1회	2	7차 회의 결정사항 정리 및 산출물 단일화	후속 운영회의(2026.4.21)
합계	8회	56		

나. 회차별 세부 실적

〈표〉 회차별 세부 실적

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
1	kick-off 회의	2025.7.26	서울의대 융합관 GDR #3	사업 범위 설정, TF 구성	TF 위원 구성 확정, 사업 범위·목표 확인, SDGs 4.7·UNESCO GCED·RALE·GRALE 5-Reimagining Our Futures 등 국제 정책 흐름과의 정합성 검토, 월 1회 정기회의 운영 합의
2	2차 회의(워크숍)	2025.8.30	서울의대 융합관 GDR #5	위원별 전문 관점 공유	김신권 「선한 사람들이 나쁜 사회를 만드는 이유」, 박보영 「세계시민의 자질: 평화와 비폭력」, 이로미 「노인 이주민 프로그램 개발」 발표. 2022 개정 교육과정과 시민성 교육의 접점 검토
3	3차 회의	2025.9.27	서울의대 융합관 523호	시민성 교육 방향 제언 초안 검토	「의학교육에서 시민성 교육방향 제언」 초안(6장 구성) 검토, 「초·중·고 시민성 교육과정 현황 분석」 보고, 연구질문 확정
4	4차 회의	2025.10.16	프레저 플레이스 센트럴 서울	교육과정 설계 템플릿	「시민성 교육과정 설계 템플릿 v1.0」 확정. 영역→졸업성과→학습성과→세부학습성과 체계 합의. 융합형 기초의학 교과목 가이드북(2023) 구조 준용 결정
5	5차 회의	2025.12.29	서울의대 국제관 옥정홀	논문·이론 정합성 검토	시민성 논문 v1.1 검토. AAMC FRAHME 프리즘 모델과 KAMC 학습성과의 융합 적용 방안 검토
6	6차 회의	2026.2.3	서울의대 국제관 옥정홀	6개 영역·졸업성과 확정	6개 영역과 6개 졸업성과 최종 확정. 논문 v2.0 검토. 중분류(역량) 용어는 별도 계층으로 표기하지 않고 졸업성과 문장에 흡수하기로 합의
7	7차 회의	2026.4.20	몬드리안 서울 이태원 호텔	세부성과 도출, KGO 매칭, 1차 콘텐츠 대상 확정	세부성과 도출 및 KGO 2판 매칭(안) 도출. 세부성과 표기를 KSA 대신 인지적·사회정서적·행동적 영역으로 전환 결정. 1차 콘텐츠 대상 영역으로 「문화적 다양성과 공존」 선정. 강의 모듈 강사 확정

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
8	후속 운영회의	2026.4.21	—	7차 회의 결과 정리	세부성과 서술 방식(3영역) 확정, 통합 구조표 단일화, 모듈 제목·강사 배정 확정, 개론 모듈 별도 제작 협의

05 주요 결과 및 성과물

1. 핵심 결과 요약

1차년도 과제 결과는 다음 세 개 명제로 요약된다.

가. 시민성 교육을 의학전문직업성의 시민적 확장으로 정립하고, 「의학전문직업성의 시민적 확장 비교표」(표장 3절)로 기존 전문직업성과의 차별적 속성을 정리하였다.

본 과제는 시민성 교육을 의학교육 외부에서 새로 도입하는 별개의 교육 영역으로 규정하지 않고, 의학전문직업성 담론 내부의 전개가 도달한 지점으로 규정하였다. 이를 위해 문헌 검토에서 확인된 현행 전문직업성 교육의 한계(현장 프레임의 개인 한정, 잠재교육과정의 지배, 표준화의 억압, 구조적 문제 앞의 무력)를 정리하고, 그 대안으로 「의학전문직업성의 시민적 확장 비교표」를 작성하였다. 이 표는 개념적 토대, 책무의 주체, 책임의 범위, 사회문제에 대한 개입, 정당화 양식, 지식의 성격, 교육의 초점 일곱 축에 대하여 2002년 의사헌장의 출발 프레임, 이후의 내적 전개, 시민적 전통이 더하는 내용을 대조한 것이다.

이 정립은 이후 산출물 전체의 기준점으로 작동하였다. 성과체계의 영역 구분과 K-MedU 강의 모듈의 주제 선정이 모두 이 프레임에 근거한다. 실무적으로는 대학이 시민성 교육을 도입할 때 신규 교과 신설이 아니라 기존 전문직업성 관련 교과의 재설계로 접근할 수 있는 근거가 된다.

나. 시민성 교육과정을 6개 영역·6개 졸업성과·18개 세부성과로 확정하고, 기본의학교육 졸업성과(KGO) 2판 18개 중 10개와의 대응 관계를 도출하였다.

한국교육과정평가원의 민주시민성 6대 지표를 의학교육 맥락으로 재구성하여 6개 영역(공공선과 공동체의식, 인간의 존엄성과 인권, 문화적 다양성과 공존, 지속가능성과 상생, 의사소통과 민주적 절차, 비판적 사고와 리터러시)을 도출하고, 영역별로 졸업성과 1개씩 총 6개를 확정하였다(6차 회의, 2026.2.3). 이어 각 영역의 세부성과를 인지적·사회정서적·행동적 3개 영역으로 서술하여 총 18개를 도출하였다(7차 회의, 2026.4.20).

세부성과 서술 체계는 당초 KSA(지식·술기·태도) 태깅 방식으로 설계되었으나, 시민성 영역에서는 하나의 성과 안에서 지식·술기·태도가 분리되지 않는다는 문제가 확인되어 UNESCO 세계시민교육의 학습성과 3영역 구조로 전환하였다. 또한 성과체계를 KGO 2판과 대조하여, KGO 2판 졸업성과 18개 중 10개가 시민성 교육 영역과 대응함을 도출하였다. 하나의 KGO가 복수의 시민성 영역에 대응하므로 영역별 대응 건수(17건)와 고유 KGO 개수(10개)는 구분하여 계상하였다. 대응이 「소통과 협력」·「사회적 책무성」·「전문직업성」 영역에 집중되어, 시민성 교육과정이 KGO의 해당 영역을 심화·확장하는 위치에 있음이 드러났다.

다. 「문화적 다양성과 공존」 영역을 우선 대상으로 5명 강연자의 12회분 공유대학(K-MedU) 강의 모듈을 개발하였다.

6개 영역을 1차년도에 모두 개발하기에는 시간·인력 제약이 있고 일부 영역이 인접 학회(의료윤리·의사소통) 활동과 중복될 우려가 있어, 7차 회의에서 영역 3 「문화적 다양성과 공존」을 우선 개발 대상으로 선정하였다. 강연자 5명이 참여하여 25분 기준 12회분의 모듈을 개발하였으며, 이 중 4회분은 시민성·전문직업성·보건의료체계를 통합하는 이론 프레임 강의로 전 영역에 공통 적용된다.

강의계획서(개설신청서 및 모듈계획서)는 작성을 완료하였으며, 촬영과 플랫폼 탑재는 1차년도 종료 시점까지 순차 진행 중이다.

2. 산출물 총괄표

〈표〉 산출물 총괄

연번	산출물명	유형	규격·분량	완료 시점	완료 여부	첨부 위치
1	시민성 교육과정 성과체계	역량·성과 체계(프레임)	6개 영역, 졸업성과 6개, 세부 성과 18개	2026. 4.	완료	부록 1
2	시민성 영역·세부성과-KGO 2판 매칭표(안)	역량·성과 체계(프레임)	영역 6개 × 고유 대응 KGO 10 개(영역별 대응 17건), xlsx 1건	2026. 4.	완료	부록 1
3	시민성 교육과정 통합 구조표	역량·성과 체계(프레임)	영역·졸업성과·세부성과·KGO 통합 1식	2026. 4.	완료	부록 1
4	K-MedU 통합 강의계획서(개설 신청서+모듈계획서)	표준양식·서식	과정 1건, 모듈계획서 일체	2026. 4.	완료	부록 1
5	K-MedU 공유대학 강의 모듈(영상)	강의콘텐츠(모듈)	강의자 5명, 25분 기준 12회분	1차년도 종료 시점	진행 중(촬영·탑재 순차 진행)	부록 1(강의계획서), 실물은 K-MedU 탑재
6	학술논문 「의학교육에서 시민성 교육의 의미와 방향: 시민적 전문직업성의 관점에서」	연구보고서·논문	원고 1편(서술적 고찰)	1차년도 종료 시점	진행 중(1차 리비전 준비 중)	부록 3
7	시민성 교육과정 설계 템플릿 v1.0	표준양식·서식	템플릿 1식(영역→졸업성과→학습성과→세부학습성과)	2025. 10.	완료	부록 4
8	초·중·고 시민성 교육과정 현황 분석	연구보고서·논문	분석 자료 1건	2025. 9. 27.	완료	부록 4
9	시민성 사례수업 예시: 리빙랩	가이드북·안내서	사례 자료 1건(7차 회의 첨부자료)	2026. 4.	완료	부록 4

3. 산출물별 상세 내용

가. 시민성 교육과정 성과체계 (총괄표 연번 1)

〈표〉 산출물 상세: 시민성 교육과정 성과체계

항 목	내 용
산출물명	시민성 교육과정 성과체계 (6개 영역·6개 졸업성과·18개 세부성과)
개발 목적·활용 대상	시민성 교육을 의과대학 교육과정 편성 단위로 전환하기 위한 상위 기준을 제공한다. 활용 대상은 의과대학 교육과정 담당 부서, 전문직업성·교양 교과 담당 교수, KAMC 공유교육과정팀이다.
개발 절차	① 초안 작성: 3차 회의(2025.9.27) 「의학교육에서 시민성 교육방향 제언」 6장 구성 초안 및 「초·중·고 시민성 교육과정 현황 분석」 검토② 설계 도구 확정: 4차 회의(2025.10.16) 「시민성 교육과정 설계 템플릿 v1.0」 확정, 영역→졸업성과→학습성과→세부학습성과 체계 합의③ 검토: 5차 회의(2025.12.29) AAMC FRAHME 프리즘 모델과 KAMC 학습성과의 융합 적용 방안 검토④ 영역·졸업성과 확정: 6차 회의(2026.2.3) 6개 영역·6개 졸업성과 최종 확정, 중분류(역량) 용어는 졸업성과 문장에 흡수⑤ 세부성과 확정: 7차 회의(2026.4.20) 및 후속 운영회의(2026.4.21) 세부성과 18개 도출, 3영역 서술 방식 확정
주요 구성·목차	① 6개 영역 정의 ② 영역별 졸업성과 6개 ③ 영역별 세부성과 18개(인지적·사회정서적·행동적 3영역 × 6영역) ④ 설계 근거 및 출처(KICE 민주시민성 6대 지표, UNESCO 세계시민교육 학습성과 3영역)
타당화·검증 근거	연구진 11명이 참여한 연구회의 6회와 워크숍 1회를 통한 반복 검토 및 합의로 확정하였다. 영역 구분은 한국교육과정평가원 민주시민성 6대 지표, 세부성과 서술 체계는 UNESCO 세계시민교육 학습성과 3영역이라는 외부 준거에 근거한다. 델파이·설문을 통한 정량적 타당화(내용타당도비율, 신뢰도 계수 등)는 수행하지 않았다.
활용 방법 및 배포 계획	통합 구조표 형태로 KAMC를 통해 전국 의과대학에 공개한다. 대학은 자체 졸업성과 체계와 대조하여 미충족 영역을 확인하고 해당 영역의 교과를 재설계하는 용도로 사용한다. 2차년도 시그니처 교과목 가이드북과 시범 적용 워크숍의 기준 문서로 승계한다.
한계 및 보완 필요사항	세분화 단계가 세부성과 수준에 머물러 있어 수업 단위 학습성과로의 세분화가 남았다. 정량적 타당화 절차와 현장 적용을 통한 검증이 이루어지지 않았다. 두 사항은 2차년도 과제로 이월하였다.

〈표〉 시민성 교육 6개 영역과 졸업성과

영역	졸업성과
1. 공공선과 공동체의식	의료 전문가로서의 정체성을 바탕으로 공동체의 건강 증진에 기여하고, 협력적 리더십을 발휘하여, 사회적 책무성을 실천한다.
2. 인간의 존엄성과 인권	보편적 인권을 옹호하며, 환자와 동료를 존중하고, 모두의 건강하고 존엄한 삶에 기여한다.
3. 문화적 다양성과 공존	사회-문화적 맥락에서 의료를 이해하고, 다양성을 존중하고, 소수자 및 취약 집단의 건강 형평성을 제고한다.
4. 지속가능성과 상생	지속가능한 미래를 위하여 생태계를 보존하고 전지구적 상생을 지향한다.
5. 의사소통과 민주적 절차	공감적 소통을 실천하고, 민주적 절차에 따라 의사결정을 하며, 보건의료 정책 수립 및 사회적 소통에 참여한다.
6. 비판적 사고와 리터러시	디지털 리터러시를 함양하고, 의료와 사회에 대한 비판적 사고를 바탕으로, 성찰적이고 창의적인 질문을 제기한다.

〈표〉 영역별 세부성과 18개와 대응 KGO 통합표

영역	인지적 영역	사회 정서적 영역	행동적 영역	대응 KGO (2판)
1. 공공선과 공동체의식	공동체 건강의 결정요인과 의료의 사회적 책무를 이해할 수 있다.	공동체의 건강 증진과 사회적 책무에 대한 책임의식을 실천할 수 있다.	공동체 건강 증진 활동에 협력적 리더십을 발휘하여 참여할 수 있다.	12 교육자 역할13 동료 소통·협력14 건강문제 파악·해결15 보건의료정책·제도17 전문직업성 증진 의무
2. 인간의 존엄성과 인권	보편적 인권의 원칙과 인간 존엄의 의미를 이해할 수 있다.	환자와 동료, 모든 인간을 존중하는 태도를 갖는다.	의료 현장에서 인권을 옹호하고 존엄한 돌봄을 실천할 수 있다.	5 환자중심 치료·관리11 환자 공감·소통16 생명윤리·의료윤리
3. 문화적 다양성과 공존	의료의 사회·문화적 맥락과 건강 형평성 문제를 이해할 수 있다.	문화적 다양성을 존중하고 소수자·취약 집단에 공감하는 태도를 갖는다.	소수자 및 취약 집단의 건강 형평성 제고에 기여할 수 있다.	11 환자 공감·소통14 건강문제 파악·해결
4. 지속가능성과 상생	의료 활동이 생태계와 전지구적 건강에 미치는 영향을 이해할 수 있다.	전지구적 건강 문제와 지속가능한 미래에 대한 책임의식을 갖는다.	지속가능한 의료 실천과 전지구적 상생을 위한 활동에 참여할 수 있다.	14 건강문제 파악·해결
5. 의사소통과 민주적 절차	공감적 소통과 민주적 의사결정의 원리를 이해할 수 있다.	민주적 절차와 사회적 소통에 대한 책임의식을 갖는다.	환자·동료·사회 구성원과 공감적으로 소통하고 민주적 의사결정 및 정책 수립에 참여할 수 있다.	11 환자 공감·소통12 교육자 역할13 동료 소통·협력15 보건의료정책·제도
6. 비판적 사고와 리터러시	디지털 정보의 비판적 평가와 리터러시의 개념을 이해할 수 있다.	의료와 사회에 대한 성찰적·비판적 태도를 갖는다.	정보를 비판적으로 평가하고 성찰적·창의적 질문을 제기할 수 있다.	9 최신 연구 결과·방법 활용18 역량 성찰·평생학습자

나. 시민성 영역·세부성과-KGO 2판 매칭표 (총괄표 연번 2)

〈표〉 산출물 상세: 시민성 영역·세부성과-KGO 2판 매칭표

항 목	내 용
산출물명	시민성 영역·세부성과-기본의학교육 졸업성과(KGO) 2판 매칭표
개발 목적·활용 대상	시민성 교육과정이 국가 수준 졸업성과 체계 안에서 어디에 위치하는지 확인하고, 대학이 시민성 교육을 신규 부담이 아니라 기존 졸업성과의 심화로 인식할 수 있도록 한다. 활용 대상은 의과대학 교육과정위원회, 인증 준비 부서, KAMC이다.
개발 절차	① 대상 확정: KGO 2판 18개 졸업성과 전문(全文) 확보② 초안 매칭: 시민성 6개 영역의 졸업성과·세부성과와 KGO 18개를 대조하여 영역별 대응 후보 도출③ 검토·조정: 7차 회의(2026.4.20)에서 과대 매칭 여부 검토, 대응 근거가 약한 항목 제외④ 도출: 영역별 대응 KGO와 KGO 영역별 분포 산출, 매칭표(xlsx) 작성. 하나의 KGO가 복수 영역에 대응하는 경우를 그대로 반영하고 고유 개수를 별도 계상⑤ 통합: 시민성 교육과정 통합 구조표에 매칭 결과 반영
주요 구성·목차	① 세부성과-대응 KGO 통합표 ② KGO 영역별 대응 분포 표(환자진료, 지식적용과 활용, 소통과 협력, 사회적 책무성, 전문직업성) ③ 매칭 해석 ④ 세부성과 단위 대조 시트(xlsx)
타당화·검증 근거	연구진의 초안 매칭을 7차 회의에서 전 항목 검토하여 합의로 도출하였다. 대응 근거가 약한 항목은 제외하여 매칭 총수를 늘리지 않는 방향으로 조정하였다. 외부 전문가 델파이나 매칭 일치도 통계는 산출하지 않았으며, KAMC 차원의 공식 승인 절차를 거친 대조표가 아니다.
활용 방법 및 배포 계획	통합 구조표와 함께 전국 의과대학에 공개한다. 대학은 자체 졸업성과-KGO 대조표에 시민성 열을 추가하는 방식으로 사용할 수 있다. 기본의학교육 인증기준(ASK)의 사회적 책무성 항목과 시민성 교육의 연계를 설명하는 근거 자료로도 사용한다. 다만 본 과제가 도출한 안이라는 성격을 함께 표기한다.
한계 및 보완 필요사항	매칭 단위가 영역 수준이어서 세부성과 대 KGO 하위 항목의 1:1 대응까지는 내려가지 않았다. 또한 하나의 KGO가 복수의 시민성 영역에 대응하는 구조여서, 영역별 대응 건수와 고유 KGO 개수가 일치하지 않는다. 이는 시민성 역량이 특정 졸업성과에 배타적으로 귀속되지 않는 성격에서 비롯된 것이지만, 대학이 자체 대조표를 작성할 때 계수 기준을 혼동할 여지가 있으므로 매칭표에 계수 방식을 명시하였다. 본 매칭은 본 과제가 도출한 안이며 KAMC 차원의 공식 확정 절차를 거친 것은 아니다.

〈표〉 복수 시민성 영역에 대응하는 KGO

KGO	성과명	대응 영역 수	대응 시민성 영역
11	환자 공감·효과적 소통	3	2. 존엄성과 인권 / 3. 문화적 다양성과 공존 / 5. 의사소통과 민주적 절차
14	건강문제 파악·해결 방안 제시	3	1. 공공선과 공동체의식 / 3. 문화적 다양성과 공존 / 4. 지속가능성과 상생
12	교육자 역할 수행	2	1. 공공선과 공동체의식 / 5. 의사소통과 민주적 절차
13	동료 소통·협력	2	1. 공공선과 공동체의식 / 5. 의사소통과 민주적 절차
15	보건의료정책·제도 이해·대응	2	1. 공공선과 공동체의식 / 5. 의사소통과 민주적 절차

〈표〉 KGO 영역별 대응 분포

KGO 영역	매칭/전체	대응 KGO
환자진료 (1~7)	1/7	5
지식적용과 활용 (8~10)	1/3	9
소통과 협력 (11~13)	3/3	11, 12, 13
사회적 책무성 (14~15)	2/2	14, 15
전문직업성 (16~18)	3/3	16, 17, 18
합계	10/18	5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

미대응 8개는 병력청취·신체진찰(1), 기본수기(2), 검사 선택·해석(3), 진단 추론(4), 의무기록(6), 환자안전(7), 과학적 지식 습득·적용(8), 연구 계획·수행(10)으로, 모두 임상 수행과 의과학 지식의 직접 수행에 해당한다. 시민성 교육과정이 이 영역을 대체하지 않는다는 점이 미대응 항목의 구성으로 확인된다.

대응은 「소통과 협력」·「사회적 책무성」·「전문직업성」 세 영역에서 전체 또는 대부분을 차지하고, 「환자진료」·「지식적용과 활용」에서는 각 1개에 그친다. 이는 시민성 교육과정이 KGO의 임상 수행 영역을 대체하는 것이 아니라 소통·책무성·전문직업성 영역을 심화·확장하는 위치에 있음을 뜻한다. 대학이 시민성 교육을 도입할 때 기존 전문직업성 관련 교과의 재설계로 접근할 수 있다는 본 과제의 설계 전제도 이 분포로 뒷받침된다.

다. K-MedU 공유대학 강의 모듈 (총괄표 연번 5)

〈표〉 산출물 상세: K-MedU 공유대학 강의 모듈

항 목	내 용
산출물명	K-MedU 공유대학 강의 모듈 「시민성 — 문화적 다양성과 공존」 (강의자 5명, 25분 기준 12회분)
개발 목적·활용 대상	성과체계와 교과 설계를 실제 수강 가능한 콘텐츠로 구현하여, 자체 개발 여력이 없는 대학도 시민성 교육을 즉시 운영할 수 있게 한다. 활용 대상은 K-MedU 회원교 학부생(의학전·임상실습전·임상실습 과정) 및 해당 교과 담당 교수이다.
개발 절차	① 대상 영역 선정: 7차 회의(2026.4.20) 「문화적 다양성과 공존」(영역 3)을 1차 개발 대상으로 선정, 인접 학회 활동과의 중복 회피 고려② 강의자 확정: 7차 회의에서 강의자 5명 및 모듈 제목·시수 배정, 후속 운영회의(2026.4.21)에서 확정③ 계획서 작성: K-MedU 통합 강의계획서(개설신청서 + 모듈계획서) 작성 완료④ 제작 협의: 공유교육과정팀과 협의하여 샘플 제작 후 승인받는 방식으로 진행⑤ 촬영·타재: 영상 제작 업체 계약 및 강의자별 촬영 일정 조율, 촬영·타재 순차 진행 중
주요 구성·목차	① 보편적 인권과 문화적 상대주의의 경계에서(김신권, 2회) ② 인종, 성별, 연령, 성 정체성, 장애의 이야기(이로미, 2회) ③ 의료데이터의 기울어진 운동장(박보영, 2회) ④ 우리 지역사회와 함께하는 리빙랩(손호준, 2회) ⑤ Citizenship, Professionalism, Health System and Medicine(오주환, 4회) ⑥ 별도: 개론 성격 모듈(의사의 시민성과 프로페셔널리즘, 세계시민성, 디지털 시민성)은 아주대학교 자체 제작
타당화·검증 근거	강의 주제와 시수는 확정된 영역 3의 세부성과에 근거하여 배정하고 7차 회의 및 후속 운영회의에서 합의하였다. 콘텐츠 품질은 공유교육과정팀과 합의한 샘플 제작·승인 절차로 확인한다. 학습자 대상 만족도 조사나 성취도 평가는 실시하지 않았다.
활용 방법 및 배포 계획	K-MedU 플랫폼에 탑재하여 전국 단위로 공유한다. 100% 온라인(강의 촬영형 및 인터뷰·대담형), 한국어 강의·한국어 자막, 별도 시험·퀴즈 없이 강의 시청 중심으로 운영하며, 교재 없이 강의 슬라이드와 참고문헌을 제공한다. 2차년도에는 나머지 5개 영역으로 단계적 확장한다.
한계 및 보완 필요사항	6개 영역 중 1개 영역만 콘텐츠 개발에 착수하였다. 촬영·타재가 진행 중이어서 완료 편수는 1차년도 종료 시점에 확정된다. 시청 중심 운영이어서 학습 확인 장치가 없다는 점도 보완 대상이다.

〈표〉 1차년도 개발 강의 모듈

연번	강의자	소속	강의 제목	시수(25분 기준)
1	김신권	아주대학교 의과대학	보편적 인권과 문화적 상대주의의 경계에서	2회
2	이로미	한국방송통신대학교	인종, 성별, 연령, 성 정체성, 장애의 이야기	2회
3	박보영	서울대학교 치의학대학원	의료데이터의 기울어진 운동장	2회
4	손호준	서울대학교 의과대학	우리 지역사회와 함께하는 리빙랩	2회
5	오주환	서울대학교 의과대학	Citizenship, Professionalism, Health System and Medicine	4회
합계				12회

1~4번은 「문화적 다양성과 공존」(영역 3) 콘텐츠이고, 5번은 시민성·전문직업성·보건의료체계를 통합하는 프레임 강의로서 전 영역의 이론 기반으로 사용된다. 5번 4회분은 당초 계획에 없던 추가 산출로, 1차년도 개발 콘텐츠가 계획 대비 확대된 부분이다.

〈표〉 K-MedU 개설 정보

항 목	내 용
과정명	시민성 — 문화적 다양성과 공존
개발 담당	이승희 (서울대학교 의과대학)
개발 구분	공동개발
개발 단위	과목(다중모듈)
대상	학부 — 의학전(premedical), 임상실습전(preclinical), 임상실습(clinical)
운영 형태	100% 온라인 (강의 촬영형 + 인터뷰·대담형)
공유 단위	전국
강의 언어	한국어 (자막 한국어)
평가	강의 시청 중심, 별도 시험·퀴즈 없음
교재	별도 교재 없음. 강의 슬라이드 및 참고문헌 제공

4. 학술적 성과

〈표〉 학술 성과

연번	제목	유형	학술지·학술대회명	일자·상태
1	의학교육에서 시민성 교육의 의미와 방향: 시민적 전문직업성의 관점에서	원저(서술적 고찰)	의학교육논단(Korean Medical Education Review), 원고번호 KMER-26-015	투고 후 수정 통보, 1차 리비전 준비 중
2	의학교육에서 전문직업성과 시민성의 연결: '시민·의사' 양성을 위한 통합적 접근	학술대회 발표(구연)	KAMC Annual Meeting	2025. 11. 14. 발표 완료

둘째 기여는 그 수렴을 시민적 전문직업성으로 정식화하고 기존 전문직업성과의 차별적 속성을 규명한 데 있다. 「의학전문직업성의 시민적 확장 비교표」에서 일곱 축의 출발 프레임과 내적 전개, 시민적 전통이 더하는 내용을 대조하여, 시민적 전문직업성이 기존 개념의 강조점 변경이 아니라 책무의 주체와 정당화의 상대를 바꾸는 확장임을 명시하였다. 이 대조표는 대학이 자체 전문직업성 교과가 어느 차원까지 다루고 있는지 점검하는 도구로도 사용된다.

셋째 기여는 이를 한국 의학교육의 교육과정·교수학습·평가 전략으로 구체화한 데 있다. 구조적 역량 교육, 지속적 관계로 설계된 지역사회 기반 학습, 의정갈등 맥락을 고려한 옹호 교육, 정책 브리프·모의 공청회를 통한 속의 학습의 네 전략을 제시하고, 기존 전문직업성 교과의 한 단위를 지역 간 의료 접근성 격차 문제로 재구성하는 5단계 예시로 실행 형태를 보였다. 평가에서는 다수 대학이 이미 도입했으나 저활용 상태인 포트폴리오를 단기 착수 지점으로 지정하여, 새 제도 도입 없이 시작할 수 있는 경로를 제시하였다.

비교표의 일곱 축 가운데 「정당화 양식」은 기존 문헌의 종합이 아니라 본 과제가 새로 제안한 결합이며, 본 과제의 독자적 학술 기여에 해당한다. Rawls의 공적 이성 개념을 전문직의 판단·설명 맥락으로 확장 적용하여, 전문직의 책임을 환자·동료에 대한 설명책임과 정부·조직에 대한 성과 책임에 이어 공적 이성에 근거한 정당화 책임으로 규정하였다. 이 규정은 한국 맥락에서 실천적 함의를 갖는다. 의정갈등 상황에서 공공선 옹호와 직역 이익 옹호를 구분하는 기준이 필요한데, 공적 이성은 그 주장이 특정 집단의 이해가 아니라 시민 일반이 수용할 수 있는 근거로 제시되었는지를 판별하는 기준을 제공한다. 나머지 6개 차원은 Sullivan, Larson, Gonzalo 등 기존 문헌의 종합이다.

이 발표는 1차년도 중간 시점에 개념 틀과 성과체계 초안을 KAMC 회원교 교수진에게 공개하고 의견을 수렴한 것으로, 발표 이후 6차·7차 회의에서 영역·졸업성과와 세부성과가 확정되었다. 논문은 초기 버전(2026.2, 시민성 개념사·국내외 현황·6대 영역 서술 구조)에서 심사 과정을 거쳐 전면 재작성되었으며, 현재 버전은 네 가지 한계 진단에서 7차원 확장, 3층위 형성 모델, 구현 전략으로 이어지는 논증 구조를 따른다. 게재 여부는 심사 결과에 따라 결정된다.

5. 확산·홍보 실적

〈표〉 확산·홍보 실적

구분	내용	대상·규모	일자
학술대회 중간발표	KAMC Annual Meeting 구연 발표 「의학교육에서 전문직업성과 시민성의 연결: '시민-의사' 양성을 위한 통합적 접근」 (발표자 김강철)	KAMC 회원교 교수진	2025. 11. 14.

확산의 주된 경로는 K-MedU 플랫폼 탑재이므로, 강의 모듈 탑재 완료 이후인 2차년도부터 대학 대상 확산이 본격화된다.

6. 산출물 저작권 및 관리

〈표〉 산출물 저작권 및 관리

산출물명	저작권 귀속	공개 범위	관리 주체
시민성 교육과정 성과체계, 시민성 영역·세부성과-KGO 2판 매칭표, 통합 구조표	KAMC 사업 산출물 규정에 따름	KAMC 결정에 따름(전국 의과대학 공개를 전제로 설계)	KAMC
K-MedU 공유대학 강의 모듈(영상) 및 통합 강의계획서	KAMC와 강의자 간 합의에 따름	K-MedU 회원교	KAMC 공유교육과정팀
학술논문 「의학교육에서 시민성 교육의 의미와 방향: 시민적 전문직업성의 관점에서」	저자 및 투고 학술지(의학교육논단, 1차 리비전 준비 중)	학술지 정책에 따름	저자
내부 검토 자료 (시민성 교육과정 설계 템플릿 v1.0, 초·중·고 시민성 교육과정 현황 분석, 회의 자료)	KAMC 사업 산출물 규정에 따름	사업 내부	과제 연구진

06 성과지표 달성도 및 자체평가

1. 성과지표 달성도

표장 2절에 제시한 1차년도(Y1) 성과지표 5개의 달성 현황은 다음과 같다. 지표는 KAMC 「의학교육혁신 사업관리 핵심성과지표(안)」의 전략목표 G4에 배정된 항목이며, 모두 산출물의 완료 여부로 판정하는 여부(Y/N) 지표이다.

〈표〉 성과지표 달성도 (KAMC 핵심성과지표 G4, Y1)

연번	성과지표명	유형	산출식·측정 방법	목표	실적	달성률(%)	판정 근거·증빙
1	시민성 중심 의학교육 과정(안) 개발 완료	정성	시민성 함양을 위한 의학교육 과정(교육목표·내용·방법·평가 포함) 개발 및 문서화 여부	Y	6개 영역·6개 졸업성과·18개 세부성과 체계, KGO 2판 매칭(안), 통합 구조표, K-MedU 통합 강의계획서 문서화 완료	100	시민성 교육과정 통합 구조표, 성과체계, 매칭표(xlsx), K-MedU 통합 강의계획서 (부록 1), 6차·7차 회의록 (부록 2)
2	시민성 교육 동영상 콘텐츠 제작 완료	정성	개발된 교육과정을 기반으로 한 교육용 동영상 제작 완료 여부	Y	강의자 5명·25분 기준 12회분 강의계획서 확정, 촬영 순차 진행 중	종료 시점 확정	K-MedU 통합 강의계획서(개설신청서·모듈계획서), 강의자별 촬영 일정 조율 기록 (부록 1)
3	시민성 교육 동영상 공유대학 탑재	정성	시민성 교육 동영상 공유대학 (K-MedU) 탑재 여부	Y	K-MedU 과정 개설신청서·모듈계획서 작성 완료, 촬영본 탑재 대기	종료 시점 확정	K-MedU 과정 개설신청서 (부록 1)
4	시민성 기반 의학교육 논문 작성 및 투고	정성	시민성을 기반으로 한 Medical Professionalism 관련 논문 초안 작성·투고 여부	Y	의학교육논단 투고(KMER-26-015), 수정 통보 후 1차 리비전 준비 중	100	의학교육논단 접수 증빙 (KMER-26-015) 및 투고 원고 (부록 3)
5	교육과정 및 연구성과 확산 활동 수행	정성	개발된 교육과정 및 논문·영상 성과를 학회·정책 회의·교육기관 등에 공유·확산 여부	Y	KAMC Annual Meeting 구연 발표(2025.11.14)	100	KAMC Annual Meeting 발표자료 (부록 3)

지표 1은 교육목표(졸업성과), 내용(영역·세부성과 및 교과목 편성), 방법(25분 모듈 단위의 조합 설계와 교수학습 전략)을 문서화하여 달성하였다. 다만 지표 정의에 포함된 평가 영역은 논문에서 단기·장기 평가 전략을 제시하는 수준에 머물렀고 실제 도구 개발에는 이르지 못하였으므로, 이 부분은 2차년도 과제로 이월하였다. 지표 4는 투고 여부로 판정하는 지표이므로 투고로 달성하였으며, 게재 확정과는 구분된다. 심사 결과 수정 통보를 받아 1차 리비전을 준비 중이다. 지표 5는 학술대회 구연 발표로 수행하였다.

지표 2와 3은 상호 연동된다. 3은 2의 산출물인 동영상에 전제하므로, 촬영이 완료되어야 탑재가 가능하다. 두 지표 모두 강의계획서 확정과 강의자 배정, 촬영 일정 조율까지 완료한 상태이며, 촬영과 탑재는 1차년도 종료 시점(2026. 8. 31.)까지 순차 진행 중이다. 따라서 달성 여부는 종료 시점에 확정된다.

2. 목표 미달·초과 항목 분석

1차년도 지표 5개 중 3개(1·4·5)는 달성하였고, 2개(2·3)는 종료 시점에 확정된다. 여부 지표의 특성상 목표를 수치로 초과하는 항목은 발생하지 않았으나, 지표 1의 산출 범위는 당초 계획을 넘어 확대되었다. 한편 성과지표에 포함되지 않은 계획 항목 2건은 1차년도 내에 완결되지 않았다. 초과·미달의 원인과 보완 계획은 다음과 같다.

〈표〉 미달·초과 항목 분석

지표	구분	원인 분석	보완 계획
시민성 중심 의학교육과정(안) 개발 완료 (지표 1)	초과	지표는 교육과정(안)의 개발·문서화 여부만을 요구하였으나, 실제로는 6개 영역 전체의 세부성과 18개와 KGO 2판 매칭(안)까지 산출하여 범위가 확대되었다. 전 영역에 공통 적용되는 이론 프레임 강의 4회분도 계획에 없던 추가 편성이다	확대된 산출 범위를 2차년도 영역 확장의 표준 절차로 문서화하고, 이론 프레임 강의는 2차년도 교과목 편성의 기반 자료로 재배치한다
시민성 교육 동영상 콘텐츠 제작 완료 (지표 2)	미확정	강의계획서 확정 이후 강의자별 촬영 일정을 순차 조율하여 진행하였다	강의자별 촬영 일정을 사전 확정하고, 2차년도에는 영역별 개발 착수 시점에 촬영 일정을 함께 배정한다
시민성 교육 동영상 공유대학 탑재 (지표 3)	미확정	지표 2의 산출물을 전제하는 후행 지표이므로 촬영 완료 이후에 판정 가능하다. 아울러 공유대학 콘텐츠 제작·심의 절차가 문서화되어 있지 않아 단계마다 개별 확인이 필요하였다	촬영 완료분부터 순차 탑재한다. 공유교육과정팀에 제작·심의 프로토콜의 문서화를 요청한다
콘텐츠 개발 영역 수 (지표 외 계획 항목)	미달	당초 복수 영역의 콘텐츠 개발을 고려하였으나 1차년도의 기간·인력 제약과 일부 영역의 인접 학회 활동 중복 우려를 고려하여 영역 3(문화적 다양성과 공존) 1개 영역으로 축소하였다	2차년도에 나머지 5개 영역(영역 1·2·4·5·6)으로 확장한다. 영역 3의 개발 절차를 표준 절차로 문서화하여 확장 시 적용한다
평가도구 개발 (지표 외 계획 항목)	미달(미착수)	평가도구는 측정 대상인 성과체계가 확정된 이후에만 설계가 가능하다. 성과체계 확정이 7차 회의(2026.4)에 이루어졌으므로 1차년도 내 착수 조건이 성립하지 않았다. 지표 1의 정의에 포함된 평가 영역이 전략 제시 수준에 머문 것도 같은 이유다	2차년도에 평가도구 개발에 착수한다. 단기적으로는 기존 전문직업성 평가 청사진에 시민적 차원의 관찰 지표를 추가하고 포트폴리오를 활용하는 방안부터 검토한다

3. 자체 평가

〈표〉 자체 평가

구 분	내 용
잘된 점	① 시민성을 의학교육 담론 내부의 언어, 곧 시민적 전문직업성으로 정립하여 학술지 투고까지 완료하였다.② 6개 영역과 졸업성과, 18개 세부성과, KGO 2판 매칭까지 성과체계를 완결하였다.③ 개념 정립에서 K-MedU 강의 모듈까지 이론과 실물 산출의 연결을 확보하였다.④ 인접 학회 활동과 중복되지 않는 영역을 우선 개발 대상으로 선정하여 1차년도 산출물의 독자성을 확보하였다.
부족한 점	① 6개 영역 중 1개 영역의 콘텐츠 개발만 완료하였다.② 평가도구 개발에 착수하지 못하였다.③ 시범운영을 통한 교육 효과 검증을 실시하지 못하였다.④ 학습성과 단위의 세분화가 세부성과 수준에 머물러 있어 수업 단위 설계에는 추가 작업이 필요하다.
예상하지 못한 성과	① 논문 심사 과정에서 논지를 전면 재구성하여 학술적 완성도가 크게 향상되었다.② 서울대학교 의과대학 리빙랩 4년 운영 경험이 시민성 교육의 실증 사례로 편입되었다.③ 이론 프레임 강의 4회분이 추가되어 개발 콘텐츠가 계획 대비 확대되었다.
종합 의견	1차년도는 개념 정립과 성과체계 확정이라는 기초 설계 단계의 목표를 달성하였고, 1개 영역의 콘텐츠 개발로 실물 산출까지 도달하였다. 2차년도에는 영역 확장과 평가 체계 개발, 대학 적용을 통해 교육과정의 실효성을 확인하는 단계로 진행할 필요가 있다.

07 성과 확산 및 활용 방안

1. 전국 의과대학 보급·확산 방안

1차년도 산출물은 성과체계(영역·졸업성과·세부성과·KGO 매칭), K-MedU 강의 모듈, 학술논문의 세 층으로 구성된다. 확산은 산출물의 성격에 따라 경로를 달리 설정하였다. 강의 모듈은 플랫폼을 통해 콘텐츠 자체를 공유하고, 성과체계는 문서와 워크숍을 통해 각 대학이 자기 교육과정에 옮길 수 있는 형태로 전달한다.

〈표〉 확산 방안

확산 대상	확산 방법	시기	기대 효과
전국 40개 의과대학	K-MedU 공유대학 플랫폼을 통한 강의 모듈 공유	2026년 하반기 이후	자체 콘텐츠와 담당 교수를 확보하지 못한 대학도 시민성 교육을 개설할 수 있다
전문직업성·교양 담당 교수	시범 적용 워크숍 (10개교 대상)	2차년도	25분 단위 모듈을 1~2시간 수업 단위로 재구성하는 실무 역량을 확보한다
의과대학 교육 책임자	시민성 교육 개요 가이드북(브로셔) 배포	2차년도	시민성 교육의 범위와 도입 방식을 요약 형태로 확인하여 교육과정 도입 의사결정을 지원한다
KAMC 회원교 교육과정 실무진	시그니처 교과목 가이드북 제작·배포	2차년도	교과목 개요부터 주차별 내용까지 9개 항목이 채워진 설계를 대학 상황에 맞추어 변형 적용할 수 있다
의학교육 연구자	학술논문 및 학술대회 발표	2026년 이후	시민적 전문직업성 개념의 학술적 검증과 확산이 이루어진다

확산 방법 간에는 선후 관계가 있다. 강의 모듈이 K-MedU에 탑재되어 실제 조화·수강이 가능해진 이후에야 워크숍에서 다룰 실물이 확보되고, 워크숍에서 확인된 재구성 사례가 가이드북의 내용을 보완한다. 따라서 2차년도 확산은 모듈 탑재 확인, 워크숍 운영, 가이드북 확정 순서로 진행하는 것이 적절하다.

2. 대학별 적용 사례

1차년도에 확인된 대학별 적용 사례는 다음 2건이다. 두 사례 모두 본 과제가 대학에 콘텐츠를 배포한 결과가 아니라, 대학이 이미 운영하거나 제작한 것이 본 과제의 산출물로 편입되거나 상호보완된 경우다.

〈표〉 대학별 적용 사례

대학명	적용 내용	적용 시기	성과·시사점
서울대학교 의과대학	「사회와 의료현장의 리빙랩」 교과 운영, 서울장애인 종합복지관 등 지역사회 기관과 연계한 실천형 교육	4년 운영	학생·당사자·현장 담당자의 경험이 본 과제의 강의 모듈 「우리 지역 사회와 함께하는 리빙랩」으로 편입되었다. 지역사회 기반 학습이 단발성 견학이 아니라 지속적 관계로 설계될 때 시민성 교육의 사례로 기능함을 보여준다
아주대학교 의과대학	시민성 개론 성격의 강의 모듈 자체 제작 (의사의 시민성과 프로페셔널리즘, 세계시민성, 디지털 시민성)	2026년	대학 자체 콘텐츠 개발과 KAMC 사업 콘텐츠가 상호보완된 사례다. 개론 영역은 대학 제작 콘텐츠로 충당하고 본 과제는 영역별 콘텐츠에 집중하는 역할 분담이 가능함을 확인하였다

그 밖의 대학 적용은 강의 모듈의 K-MedU 탑재 이후 2차년도부터 확인 가능하다. 1차년도 종료 시점까지는 촬영과 탑재가 순차 진행되므로 회원교가 접근할 수 있는 콘텐츠가 아직 확정되지 않았고, 시범 적용 워크숍도 2차년도 계획에 포함되어 있다. 따라서 적용 대학 수를 지표로 관리하는 것은 2차년도부터 의미를 가진다.

3. KAMC 플랫폼·타 과제 연계 방안

본 과제의 산출물은 KAMC 공유대학(K-MedU) 플랫폼을 통해 유통된다. 개발된 강의 모듈은 「시민성 — 문화적 다양성과 공존」 과정으로 개설되며, 전국 공유단위로 학부 전 학년(의학전·임상실습전·임상실습)이 대상이다. 25분 단위 모듈 구조는 대학이 필요한 모듈만 선택하여 조합할 수 있도록 설계되었으므로, 플랫폼의 검색 카테고리가 영역과 세부성과 단위까지 노출될 경우 활용도가 높아진다. 또한 동일 플랫폼에 탑재되는 타 과제 콘텐츠와 주제 단위로 연계 안내가 가능하도록 모듈 제목과 키워드를 성과체계 용어에 맞추어 정리하였다.

의료시스템과학(HSS) 과제와는 건강의 사회적 결정요인 영역에서 개념적으로 인접한다. 본 과제의 영역 1(공공선과 공동체의식)과 영역 3(문화적 다양성과 공존)은 건강 형평성과 구조적 요인을 다루므로 HSS 과제의 관련 주제와 중첩될 수 있다. 1차년도에는 주제 중복을 회피하는 방향으로 협의하였으며, 2차년도 영역 확장 단계에서는 중복 회피를 넘어 상호 참조 관계를 명시하는 방식이 필요하다. 동일 주제를 시민성 관점과 시스템 관점에서 각각 다루는 경우 두 콘텐츠를 함께

안내하면 학습자의 이해 범위가 넓어진다.

디지털 전환 과제와는 영역 6(비판적 사고와 리터러시)에서 접점이 있다. 디지털 리터러시와 디지털 시민성은 도구 활용 역량과 시민적 판단 역량으로 층위가 구분되므로, 디지털 전환 과제가 전자를 다루고 본 과제가 후자를 다루는 역할 구분이 가능하다. 아주대학교 자체 제작 모듈에 디지털 시민성이 포함되어 있으므로 2차년도 영역 6 콘텐츠 설계 시 해당 모듈과의 관계를 먼저 확인할 필요가 있다.

기본의학교육 졸업성과(KGO) 2판과의 관계는 본 과제 산출물의 제도적 활용 경로에 해당한다. 시민성 세부성과 18개를 KGO 2판 졸업성과 18개와 대조하여 KGO 18개 중 10개의 대응을 확정된 매칭표는 시민성 교육이 KGO의 어느 영역을 심화·확장하는지를 문서로 보여준다. 매칭이 「소통과 협력」·「사회적 책무성」·「전문직업성」 영역에 집중되고 「환자진료」 영역에는 1개만 대응된다는 결과 자체가, KAMC 성과체계 관리 측면에서 시민성 교육의 위치를 확인하는 참조 자료로 활용될 수 있다.

4. 지속 가능성 확보 방안

가. 운영 주체 및 관리 체계

강의 모듈과 성과체계 문서의 관리 주체는 KAMC로 두는 것이 적절하다. 강의 모듈은 K-MedU 플랫폼에 탑재되어 전국 공유 단위로 운영되므로 콘텐츠의 접근 권한, 갱신, 폐기 판단이 플랫폼 운영 주체와 분리되면 관리 공백이 발생한다. 성과체계 문서(통합 구조표, 시민성 영역·세부성과-KGO 2판 매칭표) 역시 KGO 개정과 연동되어야 하므로 KAMC의 성과체계 관리 업무와 같은 층에서 관리되는 것이 합리적이다.

과제 수준에서는 1차년도 연구진의 역할을 유지하되 관리 업무와 개발 업무를 구분할 필요가 있다. 1차년도에는 11명의 연구진이 개념 정립과 성과체계 설계, 콘텐츠 개발을 함께 수행하였으나, 2차년도 이후 영역이 확장되면 영역별 개발 담당과 전체 정합성 검토 담당의 구분이 필요하다. 특히 세부성과와 모듈의 대응 관계는 영역이 늘어날수록 중복과 누락이 발생하기 쉬우므로 전체를 대조하는 검토 절차를 별도로 두는 것이 적절하다.

나. 갱신·고도화 주기 및 방법

강의 모듈은 콘텐츠 성격에 따라 갱신 주기를 달리 설정하는 것이 적절하다. 개념·이론을 다루는 모듈은 갱신 필요성이 낮으나, 제도와 정책, 통계를 다루는 모듈은 내용의 시효가 짧다. 특히 시민성 교육은 사회적 쟁점과 결합되므로 사례와 수치가 시간이 지나면 현실과 어긋난다. 따라서 모듈 단위로 갱신 필요 여부를 표시해 두고 주기적으로 확인하는 방식이 관리 부담이 작다.

성과체계는 KGO 개정과 기본의학교육 인증기준 개정 시점에 맞추어 검토하는 것이 적절하다. 본 과제의 18개 세부성과와 KGO의 대응 관계는 KGO가 개정되면 다시 확인해야 하는 관계이므로, 개정 시점에 매칭표를 재검토하는 절차를 예정해 둘 필요가 있다. 또한 초·중등 2022 개정 교육과정을 이수한 학생이 입학하면 시민성 교육에 대한 사전 경험 수준이 달라지므로, 개론 모듈의 난이도와 범위를 그 시점에 재검토하는 것이 필요하다.

고도화는 세부성과의 학습성과 단위 세분화와 평가도구 개발 두 방향으로 진행한다. 1차년도 산출물은 세부성과 수준에서 멈추어 있어 수업 단위 설계에는 추가 작업이 필요하며, 평가도구가 없으면 교육 효과의 확인이 불가능하다. 두 작업은 2차년도 추진 과제에 포함되어 있다.

다. 소요 자원 및 확보 방안

지속 운영에 필요한 자원은 인력, 영상 제작 역량, 확산 운영 기반의 세 가지다. 인력 측면에서는 영역별 콘텐츠를 개발할 전문 교수와, 전체 성과체계의 정합성을 검토할 실무 인력이 필요하다. 1차년도에 확인된 애로사항은 개별 대학 소속 교수가 KAMC 사업 콘텐츠를 개발할 때 소속 대학의 실적 인정과 보상 체계가 명확하지 않다는 점이었다. 강의로 지급과 개발 실적 증빙 발급으로 1차년도에는 대응하였으나, 참여 교수의 범위를 넓히려면 KAMC 차원의 실적 인정 체계가 제도로 정비되어야 한다.

영상 제작 역량은 2차년도에 영역이 5개로 확장되면 제작 물량이 크게 증가하는 영역이다. 따라서 복수 업체 활용 또는 전담 스튜디오 확보 등 제작 역량 자체를 넓히는 방안이 필요하다. 또한 공유대학 콘텐츠 제작·심의 프로토콜이 문서화되어 있지 않아 개발 단계마다 개별 확인이 필요하였으므로, 프로토콜 문서화가 선행되면 제작 일정의 예측 가능성이 높아진다.

08 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

1차년도 추진 과정에서 실제로 발생한 쟁점과 애로사항을 아래와 같이 정리하였다. 확인된 사항은 네 가지로, 성과체계 설계 방식의 재조정, 콘텐츠 개발 범위의 축소 조정, 공유대학 콘텐츠 제작 절차의 미정비, 개발 참여 인력의 유인 부족이다.

〈표〉 쟁점·애로사항 및 개선 방안

구분	쟁점·애로사항	원인	대응 및 개선 제안
현장 운영	세부성과 서술 체계의 재설계 필요	KSA(지식·술기·태도) 단일 태깅 방식이 시민성 영역에 부적합하였다. 하나의 성과 안에서 지식·술기·태도가 분리되지 않고 함께 작동한다.	7차 회의에서 UNESCO 세계시민교육의 3영역(인지적·사회적·행동적) 서술 방식으로 전환하였다. 전환 결과를 통합 구조표에 반영하여 18개 세부성과를 재기술하였다.
현장 운영	1차년도 콘텐츠 개발 범위 조정	6개 영역 전체를 1차년도에 개발하기에는 기간과 인력이 제약되었다. 또한 일부 영역이 의료윤리·의사소통 등 인접 학회 활동과 중복될 우려가 있었다.	영역 3(문화적 다양성과 공존)을 우선 개발 대상으로 선정하고 나머지 영역은 2차년도로 이월하였다. 우선순위 선정 기준으로 산출물의 독자성을 적용하였다.
제도	공유대학 콘텐츠 제작·심의 프로토콜 미정비	KAMC 주도 콘텐츠와 개별대학 제작 콘텐츠의 절차가 구분되어 있으나 문서화된 프로토콜이 없다.	공유교육과정팀과 협의하여 샘플을 먼저 제작한 뒤 승인받는 방식으로 진행하였다. 절차의 문서화를 사업 차원에 요청한다.
인력·보상	강의 모듈 개발 참여 유인 부족	개별 대학 소속 교수가 KAMC 사업 콘텐츠를 개발할 때 소속 대학 차원의 실적 인정·보상 체계가 불명확하다.	KAMC 차원의 강의로 지급과 개발 실적 증빙 발급으로 대응하였다. 증빙이 회원교 업적평가에 반영될 수 있도록 인정 근거 마련을 요청한다.

위 쟁점 가운데 개별 과제 차원의 조치로 해소되지 않아 사업 총괄 차원의 대응이 필요한 사항은 콘텐츠 개발에 참여한 교수의 실적 인정 문제다. 본 과제의 1차년도 강의 모듈은 아주대학교 의과대학, 한국방송통신대학교, 서울대학교 치의학대학원, 서울대학교 의과대학 4개 기관에 소속된 강이자 5인이 개발하였다. 이들이 수행한 작업은 강의계획서 작성, 모듈 단위 콘텐츠 구성, 촬영 참여로 이어지는 교육개발 업무이나, KAMC 사업 참여가 소속 대학의 교육·연구 업적으로 인정되는 제도적 근거는 확인되지 않는다. 1차년도에는 KAMC 차원의 강의로 지급과 개발 실적 증빙 발급으로 대응하였으나, 그 증빙이 실제로 업적평가에 반영되는지는 대학별 내부 규정에 달려 있어 개인이 감당하는 문제로 남는다. 2차년도에는 나머지 5개 영역으로 개발을 확장할 계획이므로 참여 인력이 늘어나며, 이 상태가 유지되면 개발 참여자 확보 자체가 제약 요인이 된다. 따라서 KAMC 명의를 개발 실적 인정 근거를 마련하고, 회원교가 이를 업적평가에 반영할 수 있도록 권고하는 조치가 필요하다.

2차년도·후속 방향

나머지 다섯 영역 강의모듈과 시그니처 교과목 가이드북을 개발하고 평가도구·10개교 시범 적용 워크숍을 추진합니다.